SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT KECEMASAN PASIEN LANJUT USIA PRE OPERASI KATARAK DI KLINIK MATA UTAMA MALUKU

OLEH

INDAH LINANSERA

P1911099

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PASAPUA AMBON

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN

SULI

2023

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT KECEMASAN PASIEN LANJUT USIA PRE OPERSI KATARAK DI KLINIK MATA UTAMA MALUKU

Telah Berhasil Dipertahankan Dewan Penguji

Pada Tanggal :

Dan Diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana Keperawatan pada Program Studi Ilmu Keperawatan

Dewan Pembimbing dan Penguji :

1. Sakina Makatita S.Kep.,Ns.,M.Epid (Pembimbing) ( )
2. Nastain A. Pattimura S.Kep.,Ns.,M.Kep (Penguji 1) ( )
3. Dewi Arwini Bugis S.Kep.,Ns.,M.Kep Penguji 2) ( )

Mengetahui

Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	**Ketua Program Studi Keperawatan**
a/n	
Asriaty Dinopawe. S.ST.,M.Keb	**Harianti Fajar. S.Kep.,Ns.,M.Kes**
NIDN : 1221099001	**NIDN : 1225079001**

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal disusun oleh

Nama	:	Indah Linansera
Nim	:	P1911099
Program studi	:	Ilmu Keperawatan
Judul	:	Faktor-Faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan lanjut usia pre operasi katarak di Klinik Mata Utama Maluku

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Pada Seminar Proposal Di Hadapan Dewan Penguji

Ditetapkan di : Ambon
Tanggal : Agustus 2024

Pembimbing

Sakina Makatita S.Kep.,Ns.,M.Epid
NIDN./1218129101

YAYASAN BANGUN PERSADA
STIKES PASAPUA AMBON

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN…… ii

LEMBAR PERSETUJUAN iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR LAMPIRAN…… v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

1. Tujuan Umum 7

2. Tujuan Khusus 7

D. Manfaat Penelitian 8

1. Manfaat Teoritis 8

2. Manfaat Aplikatif 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Tinjauan Umum Tentang Katarak 10

1. Pengertian Katarak 10

2. Faktor Resiko 11

3. Klasifikasi Katarak 19

B. Tinjauan Umum Tentang Kecemasan 30

1. Pengertian Kecemasan 30

2. Tingkat Kecemasan 31

3. Respon Terhadap Kecemasan 32

4. Jenis Kecemasan 34

5. Tanda dan Gejala Kecemasan…….. 35

6. Faktor Predisposisi dan Faktor pencetus kecemasan..... 36

7. Penyebab dan Faktor yang mempengaruhi Kecemasan…… 38

C. Tinjauan Umum Tentang Pre Operasi 43

1. Pengertian Pre Operasi 43
2. Tahapan-tahapan Pre Operasi 43
3. Pengkajian pada pasien Pre Operasi..... 44
D.Tinjauan Umum Tentang jenis Kelamin……..... 50
1. Defenisi……. 50
E. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan…… 51
1. Defenisi……. 51
2. Tingkat pengetahuan di dalam domain kognitif……. 52
3. Faktor yang mempengaruhi…….. 53
F. Tinjauan Umum Tentang Dukungan Keluarga…… 56
1. Defenisi……. 56
2. Faktor yang mempengaruhi Dukungan Keluarga…….. 57
3. Jenis-jenis Dukungan keluarga…… 59
4. Manfaat Dukungan Keluarga…… 60
5. Tahapan Dukungan Keluarga…….. 60
G. Tinjauan Umum Tentang Riwayat Operasi……..... 61
BAB III KERANGKA KONSEP, HIPOTESIS DAN DEFINISI OPERASIONAL 61
A. Kerangka konsep……. 61
B. Hipotesis…… 63
C. Defenisi Operasional…….. 64
BAB IV METODE PENELITIAN 66
A. Desain Penelitian 66
B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 66
C. Populasi Penelitian 67
D. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 68
E. Instrumen Penelitian 69
F. Proses Pengolahan Data 70
G. Analisa Data..... 72
H. Etika Penelitian 73
I. Alur Penelitian..... 76
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran : Surat Pengabilan Data Awal
2. Lampiran : Lembaran Permohonan Menjadi Responden
3. Lampiran : Lembaran Persetujuan Menjadi Responden
4. Lampiran : Lembaran Kuesioner Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU RI No 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, yang dimaksud dengan lanjut usia (Lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Secara umum sesorang dikatakan lanjut usia jika sudah berusia 60 tahun, tetapi defenisi ini sangat bervariasi tergantung dari aspek sosial budaya, fisiologis dan kronologis (UU RI Indonesia No, 13 1998).

Lanjut usia merupakan bagian dari anggota keluarga dan anggota masyarakat yang semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup. *United Nation* dalam *World Population Prospects* 2022 menyatakan bahwa pada tahun 2018 penduduk lanjut usia 65 tahun ke atas untuk pertama kalinya melebihi jumlah anak yang berusia 5 tahun. Pada tahun 2022, secara global jumlah penduduk dengan usia 65 tahun keatas mencapai angka 771 juta orang, jumlah ini 3 kali lebih banyak dari jumlah pada tahun 1980 yaitu 258 juta orang. Populasi lanjut usia diproyeksikan mencapai 994 juta pada tahun 2030 dan 1.6 miliar pada tahun 2050.

Menurut World Healt Organization (WHO 2020), di kawasan Asia Tenggara populasi lansia sebesar 8% atau sekitar 142 juta jiwa. Pada tahun 2050 diperkirakan lansia meningkat 3 kali lipat dari tahun ini. Pada tahun 2000 jumlah lansia sekitar 5,300,000 (7,4%) dari total populasi, sedangkan tahun 2010 jumlah lansia 24,000,000 (9,77%) dari total populasi, dan tahun 2020 diperkirakan jumlah lansia mencapai 28,800,000 (11,34%) dari total populasi. Tercatat pada tahun 2021, presentase penduduk lanjut usia di Indonesia mencapai 10,82 % atau sekitar 29,3 juta orang. Angka tersebut menunjukan bahwa Indonesia sudah memasuki fase struktur penduduk menua yang ditandai dengan proporsi penduduk usia 60 tahun ke atas di Indonesia yang sudah melebihi 10% dari total penduduk (Badan Pusat Statistik, 2021).

Menurut Badan Pusat Statistik Maluku (2022), Prevalensi penduduk berusia lanjut di Maluku mencapai angka 162.050 jiwa atau 8.7 % jiwa. Dari peningkatan jumlah lansia dan Seiring dengan bertambahnya usia maka akan semakin banyak permasalahan kesehatan yang di alami oleh lansia. Permasalahan tersebut dapat berupa penurunan kapasitas fungsional dan juga mudah untuk terserang penyakit seperti jantung, diabetes, hipertensi, dan penyakit degenerative lainnya salah satunya gangguan penglihatan.

Berdasarkan data dari *World Healt Organization* (WHO, 2020) diperkirakan bahwa setidaknya 2,2 miliar orang memiliki gangguan

penglihatan atau kebutaan. Kasus kebutaan di dunia sebanyak 48 % disebabkan karena katarak. Katarak pada lansia menempati urutan kedua jumlah terbanyak yaitu 94 juta orang setelah jumlah penderita gangguan penglihatan jarak sedang yaitu 1 miliar. Berikut beberapa kasus katarak pada lansia menurut dari Nasional *Eye Institute* yang terjadi di berbagai Negara di dunia di Amerika Serikat sekitar 24,4 juta kasus katarak terjadi pada lansia, di Inggris sekitar 2,5 juta kasus katarak terjadi pada lansia, kemudian di India berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan India setiap tahunnya 15 juta lansia mengalami katarak (Nasional Eye Institute, 2022).

Hasil *survey Rapid Assesment of Avodable Blindness* (RAAB) oleh perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Balitbangkes di 15 provinsi yaitu di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua dengan sasaran populasi 50 tahun diketahui angka kebutaan di Indonesia mencapai 3%. Dari angka tersebut katarak merupakan penyebab tertinggi sekitar 81% . Di Indonesia terdapat 8 juta orang mengalami gangguan penglihatan sedang dan berat. Dari kasus kebutaan itu paling banyak disebabkan oleh katarak sebanyak 81,2%. Diperkirakan ada sekitar 1,3 juta penduduk Indonesia yang buta karena katarak (Kemenkes RI, 2020).

Berdasarkan data dari Klimik Mata Utama Maluku terdapat Prevalensi pasien yang berobat di Klinik Mata Utama Maluku pada tahun 2019 berjumlah 447 orang, pada bulan Oktober 2020- Februari 2021 berjumlah 189 orang, Tahun 2022 berjumlah 276 orang, dan pada bulan Januari-Agustus 2023 berjumlah 307 orang.

Katarak diperburuk oleh beberapa faktor seperti usia lanjut, cedera pada lensa mata, pemaparan yang berlebihan oleh sinar ultraviolet, radang mata, obat-obatan tertentu, alkohol, rokok atau komplikasi dari penyakit lain seperti diabetes militus (Ali, 2017). Hingga saat ini pengobatan katarak hanya bisa dilakukan dengan cara operasi. Belum ada obat-obatan,makanan,atau kegiatan olah raga yang dapat menghindarkan atau menyembuhkan seseorang dari gangguan katarak (Zorab dkk, 2019).

Tindakan operasi (pembedahan) menimbulkan krisis situasi yaitu gangguan internal yang ditimbulkan oleh peristiwa yang menegangkan, mengancam dan meningkatkan kecemasan (Hawari, 2013). Tindakan pembedahan merupakan ancaman potensial aktual terhadap integritas yang dapat mengakibatkan reaksi stress fisiologis maupun psikologis. Tindakan operasi adalah salah satu bentuk terapi yang dapat merupakan ancaman, baik potensial maupun aktual terhadap tubuh, integritas dan jiwa yang dapat mencetuskan kecemasan pada diri pasien (Srinayanti et al., 2017).

Peneltian yang dilakukan Havivah, 2019 Hasil penelitian menunjukan sebagian besar adalah jenis kelamin perempuan karena hormon estrogen pada perempuan mungkin mempengaruhi pembentukan katarak dan perempuan mengalami kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dari pada laki-laki. Kecemasan yang berhubungan dengan operasi lebih sering dialami oleh perempuan . Mereka memiliki kekhawatiran tentang kesehatan umum mereka, ketidakpastian tentang masa depan, jenis operasi dan anastesi yang akan di lakukan, ketidaknyamanan dan nyeri pasca operasi, ketidakmampuan, kehilangan kebebasan, dan takut mati juga ada di pikiran mereka.

Banyak responden memiliki pendidikan terakhir tidak luls SD karena kurangnya pengetahuan tentang penyakit dan deteksi dini katarak, kecemasan yang didapat sebagian besar cemas sedang namun ada pula yang cemas ringan karena pengetahuan ataupun informasi yang dapat dicari di luar pendidikan formal sehingga akan meningkatkan pengetahuan klien. Banyak responden baru pertama kali operasi sehingga tidak memiliki pengalaman terhadap operasi, sebagian mengalami cemas sedang, tidak pernah mengalami inilah yang menyebabkan kecemasannya lebih tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani, Donsu, dan Dewi (2020) menyatakan kondisi psikologis pasien pre operasi yang akan menjalani operasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya

dukungan keluarga. Delapan dari 10 pasien yang akan menjalani operasi merasa cemas karena pasien mengatakan takut dengan gambaran kamar operasi dan bertanya tentang bagaimana operasinya. Ketika ditanya tentang peran keluarga yang menemani, pasien menjawab bahwa peran keluarga yang menemani sedikit menenangkannya. (Ernayani. W. N, 2023)

Pada fase pre operasi, tingkat kecemasan pasien mulai meningkat terutama pada pasien yang belum pernah mengalami tindakan operasi (Wojciech R et al, 2009). Peristiwa ini merupakan hal yang paling umum dialami pasien operasi terkait beberapa dampak psikologis hingga fisiologis selama fase pre operasi (Woldegerima dkk.,2018).

Selama proses pengambilan data awal peneliti melakukan wawancara singkat dengan 4 orang pasien pre operasi dan post operasi katarak ada yang mengatakan selain karena faktor usia, kurangnya pengetahuan tentang operasi dan proses penyembuhan apakah bisa dapat melihat lagi ataukah tidak, hal ini membuat pasien merasa takut dan cemas.

Ada juga yang mengatakan bahwa merasa takut karena ini pertama kalinya pasien melakukan operasi, dan ada juga pasien yang mengatakan kurang mengetahui tentang prosesdur operasi sehingga menimbukan perasaan cemas dan takut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan lansia pre operasi katarak di Klinik Mata Utama Maluku?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

   Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pasien lansia pre operasi katarak di klinik mata utama Maluku.

2. Tujuan Khusus.

   a. Mengetahui hubungan faktor jenis kelamin dengan tingkat kecemasan pasien lansia pre operasi katarak.

   b. Menganalisis hubungan faktor tingkat pengetahuan dengan tingkat kecemasan pasien lansia pre operasi katarak.

   c. Menganalisis hubungan faktor dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien lansia pre operasi katarak.

   d. Menganalisis hubungan faktor riwayat operasi dengan tingkat kecemasan pasien lansia pre operasi katarak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk meminimalkan tingkat kecemasan lansia ketika akan melakukan tindakan keperawatan.

2. Manfaat Aplikatif

   a. Bagi Klinik mata.

      Klinik mata sebagai pemberi layanan jasa kesehatan terhadap masyarakat sehingga dalam pelaksanaan dan pemberian layanan jasa kesehatan klinik mata tahu dan dapat meminimalkan dampak katarak.dan klinik mata dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan mata di klinik mata.

   b. Bagi peneliti selanjutnya

      Sebagai masukan pengetahuan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pre operasi katarak pada lansia.dan juga sebagai masukan atau acuan untuk penelitian lebih lanjut khususnya dalam hal kecemasan lansia pre operasi katarak.

c. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendidikan khususnya STIKES Pasapua Ambon melalui publikasi ilmiah.

d. Bagi lansia

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi pasien yang pre operasi katarak, dimana pasien dapat memahami tentang tingkat kecemasan yang dialami.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Katarak

1. Pengertian katarak

Katarak adalah pengembangan dari keadaan tidak tembus cahaya dalalm lensa. Seiring bertambahnya usia, ada gangguan dalam struktur lensa dan akumulasi pigmen. Katarak ditandai dengan adanya gangguan penglihatan, penurunan tajam penglihatan secara progresif,membutuhkan lebih banyak cahaya untuk melihat hal-hal yang jelas, silau, perubahan persepsi warna dapat terjadi dengan intensitas berkurang, kurangnya kontras atau distori kekuningan. Katarak terus berkembang seiring jalannya waktu, menyebabkan kerusakan penglihatan secara progresif. (Nash, 2013).

Katarak adalah kekeruhan pada lensa mata yang mencegah terbentuknya penglihatan yang jelas. Walaupun sebagian besar kasus katarak disebabkan oleh proses penuaan terkadang katarak ditemukan pada anak-anak yang lahir dengan kondisi tersebt, atau katarak dapat terjadi setelah adanya cidera pada mata, inflamasi, maupun penyakit lainnya. Kasus katarak yang berhubungan dengan proses penuaan lensa dan paling

banyak terjadi, secara lebih spesifik jenis ini disebut sebagai *katarak Senile.* (Gracella, Styawan,& Trinigrat, 2017). Katarak merupakan penyakit mata dimana mata mengalami kekeruhan pada lensa yang diakibatkan terkumpulnya cairan di serabut lensa yang menyebabkan pandangan menjadi kabur. Perubahan lensa yang didapat terjadi pada orang berusia 60 tahun keatas.Katarak Merupakan penyebab kebutaan yang paling umum pada orang dewasa dan katarak merupakan salah satu dari tiga penyebab utama kebutaan di seluruh dunia (Olver & Lorraine 2011,h.27). Berdasarkan defenisi-defenisi di atas maka dapat di simpukan bahwa katarak adalah kekeruhan lensa mata atau kapsul lensa mata yang menyebabkan gangguan penglihatan.

2. Faktor Resiko

Katarak pada dasarnya terjadi akibat proses penuaan/degeneratif. (Khurana, 2007) Beberapa factor yang terlibat antara lain:

a. Umur

Katarak merupakan proses degeneratif yang sangat dipengaruhi umur. Dengan meningkatnya umur harapan hidup maka proporsi penduduk umur > 60 tahun akan

meningkat sehingga jumlah penderita katarak juga akan makin meningkat. (Kementrian Kesehatan RI, 2018).

Katarak beresiko pada orang > 60 tahun, tidak terkait trauma mekanis, kimia, atau radiasi yang diketahui. Ini menjadi semakin parah dan sering terjadi pada orang lanjut usia. Kerusakan dan agregasi protein,kerusakan membrane sel serat, defisiensi glutathione, kerusakan oksidatif, peningkatan kalsium, migrasi sel epitel lensa abnormal, dan beberapa factor lain adalah beberapa mekanisme spesifik yang bertanggng jawab atas katarak yang berkaitan dengan usia. (Gupta, Rajagopala, & Ravishankar, 2014).

b. Jenis Kelamin

Katarak lebih umum terjadi pada wanita menopause dibandingkan pada pria usia yang sama, ini menunjukan kemungkinan peran estrogen. Reseptor estrogen telah terdeteksi di lensa mata katarak. Estrogen yang terjadi secara alami (endogen) tampaknya melindungi mata dari katarak, bersama dengan system system tubuh lainnya sebelum menopause. Sebah studi prospektif pada wanita swedia pasca menopause menemukan bahwa *HRT* (*Hormonal Replacement Therapy*) juga dapat meningkatkan risiko katarak. (Gupta, Rajagopala, & Ravishankar, 2014).

c. Genetik

Katarak oleh faktor genetik disebabkan oleh anomali pada pola kromosom induvidu. Sekitar 33% dari sema katarak kongenital adalah keturunan. Hal ini juga memainkan peran penting dalam kejadian katarak, usia, onset dan pematangan katarak dalam keluarga yang berbeda (Khrana, 2007).

Gen PITX3 dilaporkan bertanggung jawab atas beberapa katarak yang diturunkan pada disgenesis mesenkim segmen anterior. Katarak diturunkan dari sifat dominan autosomal dan resesif autosomal atau sifat X-linked. Secara fenotip, katarak identik dapat terjadi akibat mutasi pada lokus genetik yang berbeda dan mungkin memiliki pola pewarisan yang berbeda. (Gupta,Rajagopala, & Ravishankar, 2014).

d. Ras/Etnik

Orang Afrika – Amerika dan Hispanik Amerika tampaknya memiliki risiko hampir dua kali lipat terkena katarak dibandingkan orang Kaukasia. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh penyakit medis lainnya, terutama diabetes, dan karena kurangnya pengobatan. (Gupta, Rajagopala, & Ravishankar, 2014).

Orang kulit putih memiliki prevalensi lebih tinggi, dan orang yang berasal dari etnis Asia memiliki prevalensi lebih tinggi daripada orang eropa. (Alshamrani,2018).

e. Pekerjaan

Orang yang bekerja dalam kondisi berbahaya seperti tukang las dan di tungku kaca lebih rentan terkena katarak. (Gupta, Rajagopala, & Ravishankar, 2014).

f. Merokok

Merokok telah dilaporkan memiliki beberapa efek pada proses terjadinya katarak Senile. Merokok menyebabkan penumpukan molekul berpigmen 3-hidroksi kynurenine dan kromofor, yang menyebabkan karbamilase dan denaturasi protein. (Khurana, 2007).

g. Paparan Sinar Ultraviolet (UV)

Faktor utama yang menentukan apakah radiasi akan melukai mata manusia adalah intensitas cahaya, panjang gelombang yang dipncarkan dan diterima oleh jaringan mata, dan usia penerima. (Robert, 2011)

Sebagian besar intensitas cahaya, semakin besar, semakin kemngkinan merusak mata. Semakin pendek panjang gelombangnya, semakin besar energinya maka semakin besar potensi radiasi merusak, semua radiasi dibawah 295 nm (Sema UV-C dan sebagian UV-B) disaring

kornea sebelm mencapapi lensa. Lensa tetap bening selama 3 tahun pertama kehidupan dan kemudian secara bertahapa mengembangkan pigmen kuning (3-hidroksi kynurenine dan glukosida) sebagai pelindung, yang menyerap radiasi UV dan menghilangkan energinya dengan aman, seiring betambahnya usia, pigmen pelindung secara enzimatis diubah menjadi asam xanturenik kromofor fototoksik. Asam xanturenik di lensa menyerap radiasi UV, membentuk triplet, dan menghasilkan oksigen singlet dan superoksida. Pada saat yang sama, terjadi penurunan produkksi antioksida dan enzim antioksida, yang biasanya akan menghilangkan spesies oksigen reaktif ini, Akibatnya, baik sel epitel lensa maupn protein lensa mengalami kerusakan, yang pada akhirnya menyebabkan lensa menjadi buram. (Roberts, 2011).

h. Stress Oksidasi – Radikal Bebas (Oksidans)

Proses oksidatif meningkat seiring bertambahnya usia pada lensa manusia, dan konsentrasi protein ditemukan secara signifikan lebih tinggi pada lensa katarak. Produksi oksidan yang berlebihan sangat berbahaya bahkan dapat mempengaruhi materi genetik. Satu teori mendalilkan bahwa pada mata yang menua, penghahalang berkembang yang mencegah *gluthione* dan antioksidan pelindung lainnya

mencapai nukleus di lensa, sehingga membuatnya rentan terhadap oksidasi. (Gupta, Rajagopala, & Ravishankar 2014).

i. Alkohol

Alkohol meningkatkan risiko katarak nukleus, korkitkal, dan subkapsular posterior (PSC). Lensa sensitif terhadap stress oksidatif dan mengarahkan efek toksik alkohol. Tingkat terendah yang menunjukan efek dalam penelitian adalah 91g etanol murni per minggu, minuman standar 4,6 lebih mungkin untuk menderita PSC jika dibandingkan dengan bukan peminum. (Gupta, Rajagopala, & Ravishankar 2014).

j. Infeksi

Infeksi pada ibu seperti rubella dikaitkan dengan katarak pada 50% kasus. (Khurana, 2007). Penyakit infeksi intrauterine yang paling sering menyebabkan katarak kongenital adalah rubella, campak, herpes, simplex, varicella, virs *Epstein-Barr,* influenza, toksoplasmosis dan sifilis. Kekeruhan lensa dapat memiliki banyak tampilan berbeda, tergantung pada bagian tertentu yang terpengaruh. (Kohnen, Baumeister, Kook, Klaporth, & Ohrloff, 2009).

k. Trauma

Katarak dapat terbentuk setelah cedera tumpul dan masuknya benda asing yang sulit dikeluarkan, menyebabn keruskan fisik. Ketika kapsul lensa luar pecah, lensa bagian

dalam membengkak karena air dan berubah menjadi putih karena denaturasi protein lensa. Cedera pada lensa tanpa pecahnya kapsul dapat menyebablan katarak yang awalnya sub-kapsul dan umumnya memiliki penampilan berbentuk bintang. Cedera ini biasanya terjadi pada pria muda, dan lensanya mudah untuk dikeluarkan. (Gupta, Rajagopala, & Ravishankar 2014)

l. Nutrisi dan Status Gizi

Diet kekurangan protein tertentu, asam amino, vitamin (riboflavin, vitamin E, vitamin C), dan unsur-unsur penting juga menjadi penyebab awal dan pematangan katarak *senile* (Khrana, 2007). Study telah menununjakan bahwa kekurangan nutrisi dari mikronutrein berhubungan dengan katarak. *Aldosa reduktase* adalah dasar untuk pembentukan katarak yang berhubungan dengan kelainan dalam metabolisme gula. Studi menunjukan bahwa status gizi yang buruk pada pasien katarak mempercepat insolubilisasi protein di lensa. (Gupta, Rajagopala, & Ravishankar 2014)

m. Riwayat Penyakit (Diabetes Melitus)

Diabetes Melitus akan mengakibatkan peningkatan proses metabolisme sorbotil pada lensa, sehingga katarak dapat lebih cepat terbentuk. (Anisa, 2018). Hiperglikemia tercermin dalam kadar glukosa yang tinggi dalam humor

akuos, yang tersebar ke lensa dimetabolisme dengan menggunakan *aldosa reduktase* menjadi sorbotil, yang kemudian terakumulasi dalam lensa sehingga mengakibatkan hiperhidrasi osmotik sekunder pada subtansi lensa. Hal ini mempengaruhi indeks bias lensa dengan akibat fluktuasi refraksi yang berkaitan dengan kadar glukosa dalam darah. (Cerim, Dizdarevic, & Pojskic, 2014).

n. Riwayat Penggunaan Obat

penggunaan steroid adalah faktor resiko keempat untuk katarak sekundar dan menyumbang 4,7% dari semua ekstraksi katarak. Steroid, seperti prednisone, memblokir metabolisme normal jaringan ikat, di mana lensa tersusun. Bahkan krim steroid potensi rendah yang dioleskan ke kelopak mata dapat menyebabkan peningkakatan tekanan intra-okular dan katarak. Mekanisme katarak yang di induksi kortikosteroid tidak diketahui secara pasti tetapi mungkin disebabkan oleh ketidakseimbangan osmotik, kerusakan oksidatif, atau gangguan faktor pertumbuhan lensa. Obat neuroleptik digunakan dalam pengobatan berbagai gangguan kejiwaan. Terapi Klorpromazin (CPZ) dikaitkan dengan pigmentasi lensa kapsul anterior, diikuti oleh perubahan pigmen endotel kornea. Selama terapi karbamazepin, penglihatan kabur, diplopia sementara, dan konjungtivitas,

selain keruhan lensa, telah dilaporkan. Gangguan penglihatan tersebut revresibel dan merespon penurunan dosis. (Gupta, Rajagopala, & Ravishankar 2014)

3. Klasifikasi Katarak

Katarak diklsifikasikan dalam dua divisi utama (American Academy of Oftalmology 2008), yaitu:

a. Katarak Developmental

1) Katarak Kongenital

Katarak yang terjadi setelah lahir pada satu atau kedua mata. Katarak kongenital adalah katarak yang mulai terjadi sebelum atau segera setelah lahir dan bayi berusia < 1 tahun. Katarak kongenital sering ditemukan pada bayi yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang menderita penyakit rubella, galaktosemia, homosisteinuri, diabetes militus, hipoparatirodism, toksoplasmosis, inklusi sitomegalik, dan histoplamosis. Penyakit lain yang menyertai katarak kongenital biasanya merupakan penyakit-penyakit herediter seperti mikroftlamus, aniridia, koloboma iris, keratokonus, iris heterokrimia, lensa ektopik, displasi retina, dan megalo korena. (Ilyas, 2009).

2) Katarak Juvenil

Katarak yang ditemukan sejak bayi atau dimasa kanak-kanak. Kekeruhan lensa terjadi pada saat serat-serat

lensa masih berkembang. Katarak mulai terbentuk pada masa usia kurang dari 9 tahun dan lebih dari 3 bulan. Katarak ini ditemukan saat lahir sampai usia dewasa. Disebabkan oleh penyakit hrediter dan bisa merupakan kelanjutan dari katarak kongenital.

b. Katarak Degeneratif

1) Katarak senilis

Katarak senilis adalah kekeruhan pada lensa mata yang menyebebkan penurnan ketajaman penglihatan (virus) yang paling sering berkaitan dengan proses degenerative lensa pada pasien usia diatas 40 tahun. Penyebab lain katarak adalah glaukoma, trauma mata, uveitis serta kelainan sistematik seperti riwayat pemekaian obat steroid, diabetes militus dan lain-lain. Katarak biasanya terjadi biletar, namun dapat juga pada satu mata (monokular) (Faqih 2013).

Komponen terbanyak dalam struktur lensa adalah air dan protein. Bertambah tuanya usia sesorang akan mengakibatkan lensa kekurangan air dan menjadi lebih padat di bagian tengahnya, sehingga menyebabkan kemampuan fokus untuk melihat benda dekat semakin berkurang. Orang dengan usia lanjut akan mengalami pembentukan lapisan koertikal yang baru pada lensa yang

mengakibatkan nukleus lensa terdesak dan mengeras atau yang dikenal sebagai skerosis nukleur. Saat usia lanjut terjadi, perubahan protein lensa akan terjdi seperti terbentuknya protein dengan berat molekul yang tinggi dan mengakibatkan perubahan indeks refraksi lensa sehingga memantulkan sinar yang masuk dan mengurasi trasparansi lensa. Perubahan kimia ini akan diikuti dengan pembentukan pigmen pada nuclear lensa (Vaughan, Asburi, dan Riordan-Eva 2000).

Lensa akan terlihat atau bersifat bening pada keadaan normal. Sering dengan bertambahnya usia seseorang, lensa mata dapat mengalami perubahan warna menjadi kuning keruh atau coklat keruh. Proses ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan (pandangan kabur/buram) pada seseorang. Kekeruhan lensa ini mengakibatkan lensa tidak transparan sehingga pupil berwarna abu-abu dan putih. Kekeruhan ini juga dapat ditemukan pada berbagai lokasi di lensa seperti korteks dan nukleus. Fondus oculi menjadi semakin sulit dilihat seiring dengan semakin padatnya kekeruhan lensa bahkan reaksi fondus bisa hilang sama sekali (Vaughan,Asburi, dan Riordan-Eva 2000).

Katarak senilis memiliki tiga tipe utama yaitu:

a) Katarak Nuklear

Skelerosis dan penguningan nuklear pada tingkatan tertentu dianggap normal setelah usia pertengahan. Umumnya, kondisi ini hanya sedikit mengganggu fungsi penglihatan. Jumlah sclerosis dan penguningan yang berlebihan disebut katarak nuklear, yang menyebabkan opasitas sentral. Tingkatkan sklerosisi, penguningan dan opasfikasi dinilai dengan menggunakan biomikroskop slit-lamp pemeriksaan reflex merah dengan pupil dilatasi (Vaughan et al. 2012).

Katarak nukleur cenderung berkembang dengan lambat. Katarak nuclear bisa terjadi asimetrik, namun sebagian besar katarak nuklear adalah bilateral. Ciri khas dari katarak nuklear adalah membaiknya penglihatan dekat tanpa harus menggunakan kacamata, keadaan inilah yang disebut sebagai “penglihatan kedua”. Hal ini merupakan akibat dari meningktnya kekuatan fokus lensa bagian sentral yang menyebabkan refraksi beregeser ke myopia (penglihatan dekat). Kadang-kadang, perubahan mendadak indeks refraksi antara nukleus sklerotik dan korteks lensa dapat menyebabkan monocular diplopia.

Penguningan lensa yang progresif menyebabkan diskiminasi warna yang buruk. Pada kasus yang sudah lanjut, nucleus lensa opak dan coklat dan disebut katarak nuclear brunescent. Secara histopatologi. Karakteristik katarak nuklearis adalah homogenitas nucleus lensa dengan hilangnya lapisan tipis seluler (Vaughen et al. 2012).

b) Katarak Kortikol adalah kekeruhan pada korteks lensa. Ini adalah jenis katarak yang paling sering terjadi. Lapisan korteks lensa tidak sepadat pada bagian nukleus sehingga lebih mudah terjadi overhidrasi akibat ketidakseimbangan elektrolit yang mengganggu serabut korteks lensa sehinggga terbentuk osifikasi kortikal, yang tunjukan pada diabetes dan glaktosemia (Fong,2008).

Perubahan hidrasi serat lensa menyebabkan terbentuknya celah-celah dalam pola radial di sekeliling daera ekuator. Katarak ini cenderung bilateral,tetapi sering asimetrik. Derajat gangguan fungsi penglihatan bervariasi, tergantung seberapa dekat kekeruhan lensa dengan sumbu penglihatan (Harper et al, 2010). Gejala yang sering ditemukan adalah penderita merasa silau pada saat mencoba

memfokuskan pandangan pada suatu sumber cahaya di malam hari (Rosenfeld et al, 2007).

Pemeriksaan menggunakan biomikroskop slitlamp akan mendapatkan gambaran vakuola, degenerasi hiropik serabut lensa serta pemisahan lamella kortek anterior atau posterior oleh air. Kekeruhan putih seperti baji terlihat di perifer lensa dengan ujungnya mengarah ke sentral, kekeruhan ini tampak gelap apabila dilihat menggunakan retroiluminasi . Secara histopologi, karakteristis dari katarak kortikal adalah adanya pembengkakan hidrofik serabut lensa. Globula morgagni (globules-globulus material eosinofiklik) dapat diamati di dalam celah antara serabut lensa (Rosenfeld et al, 2007).

c) Katarak subkapsularis posterior

Katarak subkapsularis posterior terdapat pada korteks di dekat kapsul posterior bagian sentral (Harper et al, 2010). Katarak ini biasanya didapatkan pada penderita dengan usia yang lebih mudah disbanding kedua jenis katarak yang lain. Gejalany antara lain adalah fotodobia dan penglihatan yang buruk saat mata berakomodasi atau diberikan miotikum. Ini dikarenakan ketika pupil konstriksi saat

berakomodasi, cahaya yang masuk ke mata menjadi terfokus ke sentral, diamana terdapat katarak subkapsularis posterior, menyebabkan cahaya menyebar dan mengganggu kemampuan mata untuk memfokuska pada macula (Rosenfeld et al, 2007).

Deteksi katarak subkpsularis posterior paling baik menggunakakan biomikroskop slitlamp pada mata yang telah ditetesi midriatikum. Pasca pemebentukan katarak akan ditemukan gambaran kecerahan mengkilap seperti pelangi yang halus pada korteks posterior (Rosenfeld et al, 2007).

Sedangkan tahap akhir terbentuk kekeruhan granular dan kekeruhan seperti plak di kortek subkapsularis posterior. Kekeruhan lensa di sini dapat timul akibat trauma, penggunaan kortikosteroid (topical atau sistemik), peradangan atau pajanan radiasi pengion (Harper et al, 2010).

Katarak senil biasanya berkembang lambat selama beberapa tahun, kekeruhan lensa dengan nukleus yang mengeras akibat usia lanjut yang biasanya mulai terjadi pada usia lebih dari 60 tahun.

Katarak senil secara Klinik dikenal dalam 4 stadium, yaitu:

a) Stadium insipen merupakan stadium dini katarak dan pada stadium ini terjadi kekeruhan lensa sektoral *berupa spokes pf wheel* (seperti biji atau roda). Pada stadium ini proses degenerasi belum menyerap cairan mata ke dalam lensa sehingga akan terlihat bilik mata depan dengan dengan kedalaman yang normal. Iris dalam posisi biasa disertai dengan kekeruhan ringan pada lensa. Tajam penglihatan belum tergganggu (Ilyas 2005).

b) Katarak stadium

insipen terjadi kekeruhan mulai dari tepi ekuator menuju korteks anterior dan posterior (Katarak kortikal). Vakuol mulai terlihat di dalam korteks. Kekeruhan katarak subkapsular posterior, kekeruhan mulai terlihat di anterior sub kapsularis posterior, celah berbentuk serat lensa dan korteks, berisi jaringan degenerative (benda morgagni). Kekeruhan ini dapat menimbulkan poliopia karena indeks refraksi yang tidak sama pada semua bagian lensa. Bentuk ini kadang menetap untuk waktu yang lama. Pasien akan mengeluh gangguan penglihatan seperti melihat ganda dengan satu matanya (Ilyas dan Yulianti 2011).

c) Stadium imatur:

sebagai lensa keruh atau katarak Merupakan katarak yang belum mengenai seluruh lapis lensa. Volume lensa bertambah akibat meningkatnya tekanan osmotic pada degenerative lensa. Pada keadaan lensa mencembung akan dapat menimbulkan hambatan pupil, sehingga terjadi glaukoma sekunder (Lang 2000).

Katarak intumesen: kekeruhan lensa disertai pembengkakan lensa akibat lensa yang degenerative menyerap air. Pada keadaan ini dapat terjadi hidrasi korteks hingga lensa akan mencembung dan daya biasanya bertambah, yang akan memberikan miopisasi (Harper et al, 2009).

d) Stadium matur

merupakan proses degenerasi lanjut lensa. Pada stadium ini terjadi kekeruhan lensa. Tekanan cairan di dalam lensa sudah dalam keadaan seimbang. Tajam penglihatan menurun dan hanya tinggal proyeksi sinar positif. Stadium ini tepat untuk melakukan operasi karena kekaburan lensa sudah lebih padat dan lebih mudah dipisahkan dari kapsulnya.

e) Stadium hirpermatur

terjadi proses degenerasi lanjut dan korteks lensa dapat mencair sehingga nukleus lensa tenggelam di dalam korteks lensa (Katarak morgagni). Pada stadium ini terjadi juga degenerasi kapsul lensa sehingga bahan lensa ataupun korteks lensa yang cair keluar dan masuk kedalam bilik mata depan. Lensa terlihat lebih kecil dari pada normal, yang akan mengakibatkan iris tremulans, dan bilik mata terbuka. Pada uji bayangan iris terlihat positif walaupun seluruh lensa telah keruh sehingga pada stadium ini disebut uji bayangan iris pseudopositif. Akibat bahan lensa keluar dari kapsul, maka akan timbul reaksi pada jaringan uvea berupa uvetis. Bahan lensa juga dapat menutup jalan keluar cairan bilik mata sehingga timbul glaukoma fakolitik (Ilyas, 2006).

2) Katarak Radiasi

Jenis katarak ini mempunyai perkembangan yang lambat, mulai pada bagian posterior korteks kira-kira 2 tahun sesudah eksposur dengan sinar radium atau rontgen.

3) Katarak Komplikata

Katarak yang berhubungan dengan penyakit mata lainnya seperti, iridosiklitis, koroiditis, uveitis, ulkus kornea, glaukoma, ablasio, retina, dan tumor intraocular.

4) Katarak Metabolik

Diabetes militus merupakan predisposisi untuk berkembang menjadi katarak senilis. Selain itu, katarak yang berhubungan dengan penyakit sistemik lainnya adalah katarak galaktosemik, Katarak hipoklasemik (tetanik, katarak defisiensi gizi,katarak aminoasiduria, penyakit Wilson dan katarak yang berhubungan dengan penyakit metabolik lain (Barnard, 2003).

5) Katarak Traumatika

Katrak yang disebabkan oleh trauma pada lensa mata, dapat berupa trauma tumpul atau trauma tajam, adanya benda asing pada intraokuler, X-Ray yang berlebihan atau bahan radioaktiif. Waktu untuk perkembangan katarak traumatic bervariasi dari jam sampai tahun (Ocampo, 2009).

6) Katarak Toksik

Pembentukan katarak yang berhubungan dengan keracunan bisa disebabkan oleh kortikosteroid sistemik atau topical ergot, dinitrophenol dan napthalence.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG KECEMASAN

1. Pengertian Kecemasan

Kecemasan merupakan bagian kehidupan manusia yang ditandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan (Fatmawati, 2013). Kecemasan adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami perasaan gelisah dan aktivitas saraf otonom terhadap ancaman yang tidak jelas dan tidak spesifik (Carpenito, 2006). Kecemasan adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar yang berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya keadaan emosi ini tidak memiliki objek yang spesifik (Stuart, 2007).

Kecemasan (*ansietas*) adalah gangguan alam perasaan (*affective*) yang ditandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, tidak mengalami gangguan dalam menilai realistis (*Reality Testing Abality/RTA* masih baik), kepribadian masih tetap utuh (tidak mengalami keretakan kepribadian/*spilitting of personality*), Perilaku dapat terganggu tetapi masih dalam batas-batas normal (Murdiningsih, 2013). Sedangkan menurut Videback (2008), Ansietas adalah perasaan takut yang tidak jelas dan tidak didukung oleh situasi. Gangguan ansietas adalah sekelompok

kondisi yang memberi gambaran penting tentang ansietas yang berlebihan disertai respon,perilaku, emosi dan fisiologis.

Menurut peneliti kecemasan merupakan perasaan gelisah, tidak jelas dan takut.

2. Tingkat Kecemasan

Menurut Stuart & Sundeen (1998) tingkat kecemasan dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Mild Anxiety (Kecemasan Ringan)

   Ketererangan dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan lahan persepsinya. Kecemasan dapat memotivasi belajar dan pertumbuhan serta meningkatkan kreativitas. Gejala kecemasan nafas pendekatan sesak, gemetar tidak cepat istirahat dengan tenang, suara tidak stabil, kening berkerut.

2. Moderate Anxiety (Kecemasan Sedang)

   Lahan persepsi terhadap lingkungan menurun. Individu lebih memfokuskan pada hal penting saat itu dan mengesampingkan hal yang lain. Gejala kecemasan gelisah, mulut kering, suka buang air besar,dan tidur tidak nyenyak.

3. Severe Anxiety (Kecemasan Berat)

Lahan persepsi menjadi sangat sempit. Individu cenderung memikirkan hal-hal yang kecil saja dan mengabaikan hal yang lain. Individu tidak mampu berpikir berat lagi dan membutuhkan banyak pengarahan atau tuntunan. Gejala kecemasan mudah berkeringat, penglihatan kabur, kepala pusing dan merasa tegang.

4. *Panic* (Panik)

Lahan persepsi sudah tergganggu sehingga individu sudah tidak dapat mengendalikan lagi dan tidak dapat melakukan apa-apa, walaupun sudah diberikan pengarahan atau tuntunan. Gejala kecemasan rasa tercekik, nafas pendek, nyeri dada, muka merah dan pucat.

3. Respon Terhadap kecemasan

Menurut Stuart & Sunden (1998), respon terhadap kecemasan diantaranya yaitu:

1. Respon Fisiologi
   a. Kardiovaskuler meliputi : palpitasi, jantung berdebar, tekanan darah meninggi, rasa mau pingsan, tekanan darah menurun dan denyut nadi menurun.
   b. Pernafasan meliputi : nafas cepat, sesak nafas, tekanan pada dada, nafas dangkal, pembengkakan pada tenggorokan, sensasi tercekik dan terengah-engah.

c. Neuromuskuler meliputi : reflex meningkat, reaksi terkejut, mata berkedip-kedip, insomnia, rigiditas, gelisah, wajah tegang, kelemahan umum, tungkai lemah dan gerakan yang jangkal.

d. Gastroinstentinal meliputi : kehilangan nafsu makan, menolak makan, rasa tidak nyaman pda abdomen, mual, nyeri uluh hati dan diare.

e. Traktus urinarius meliputi : tidak dapat menahan kencing, sering berkemih.

f. Kulit meliputi : wajah kemerahan, berkeringat setempt (telapak tangan gatal), rasa panas dan dingin pada kulit, wajah pucat, berkeringat seluruh tubuh.

2. Respon Psikologis

a. Respon perilaku

Meliputi gelisah, ketegangan fisik, tremor, reaksi terkejut, bicara cepat, kurang koordinasi, cenderung mendapat cedera, menarik diri dari hubungan interpersonal, menghalangi, menarik diri dari masalah, menghindari, hiperventilasi (Stuart & Sundeen, 1998).

Menurut Potter & Perry (2010), perilaku adaptif psikologi dapat kontruktif dan destruktif. Perilaku konstruktif membantu individu menerima tantangan untuk menyelesaikan konflik. Bahkan ansietas dapat konstruktif,

misalnya: ansietas dapat menjadi tanda bahwa terdapat ancaman sehingga seseorang dapat melakukan tindakan untuk mengurangi keparahannya. Perilaku destruktif mempengaruhi orientasi realitas, kemampuan pemecahan masalah, kepribadian dan kemampuan untuk berfungsi terhadap situasi yang sangat berat. Ansietas juga dapat bersifat destruktif, misalnya : jika seseorang tidak mampu bertindak melepaskan diri dari stressor. Sama haknya penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan dapat dipandang sebagai perilaku adaptif. Namun dalam kenyataannya hal ini malah meningkatkan stress dan bukan menurunkan stress.

b. Respon kognitif

Meliputih: perhatian terganggu, konsentrasi buruk, pelupa, salah dalam pemberian penilaian, preokupasi, hambatan berfikir, bidang persepsi menurun, kreativitas menurun, produktivitas menurun, bingung, sangat waspada, kesadaran diri meningkat, kehilangan objektifitas, takut, kehilangan control, takut pada gambaran visual, takut cidera atau kematian, dan mimpi buruk.

c. Respon Efektif

Meliputi: mudah terganggu, tidak sabar, geliah, tegang, gugup, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, mati rasa, rasa bersalah.

4. Jenis Kecemasan

Ada tiga jenis kecemasan menurut Freud dalam Zaviera (2007) sebagai berikut :

a. Kecemasan realistis

Kecemasan realistis adalah ketakutan terhadap bahaya dari dunia eksternal, dan taraf kecemasannya sesuai dengan derajat ancaman yang ada. Kecemasan jenis ini disebut juga sebagai rasa takut.

b. Kecemasan Moral

Kecemasan moral adalah ketakutan terhadap hati nurani sendiri. Kecemasan moral ini adalah kata lain dari rasa malu, rasa bersalah atau rasa takut mendapat sanksi.

c. Kecemasan Neurotic

Kecemasan neurotic adalah ketakutan terhadap tidak terkendalinya naluri-naluri yang menyebabkan seseorang selalu melakukan suatu tindakan yang bisa mendatangkan hukuman bagi dirinya. Neurotic adalah kata latin dari perasaan gugup.

5. Tanda dan Gejala Kecemasan

Menurut Prabowo (2014), tanda dan gejala kecemasan sebagai berikut :

a. Kecemasan yang berelbihan.
b. Sering khawatir bila berada dalam situasi yang baru.
c. Ragu-ragu.
d. Sering mengalami takut-takutan (takut gelap, orang asing, guntur, dan binatang).
e. Sering insomnia dan mimpi buruk.

6. Faktor Predisposisi dan Faktor Pencetus Kecemasan

Menurut Stuart (2007), faktor predisposisi terjadinya kecemasan diantaranya adalah :

a. Pandangan Psikoanalitik

Menurut pandangan psikoanalitik, kecemasan terjadi karena adanya konflik emosional yang terjadi antara dua elemen kepribadian yaitu id dan super ego. Id mewakili dorongan insting, super ego mewakili hati nurani dan dikendalikan oleh norma budaya, sedangkan ego berfungsi menengahi tuntutan dari dua elemen yang bertantangan, dan fungsi ansietas adalah meningkatkan ego bahwa ada bahaya.

b. Pandangan Interpersonal

Menurut pandangan interpersonal kecemasan timbul dari perasaan takut terhadap tidak adanya penerimaan dan

penolakan interpersonal. Ansietas juga berhubungan dengan perkembangan trauma, seperti perpisahan dan kehilangan, yang menimbulkan kelemahan spesifik. Orang dengan harga diri rendah trauma mudah mengalami perkembangan ansietas yang berat.

c. Teori Behaviour (perilaku)

Berdasarkan teori behavior (perilaku), kecemasan merupakan produk frustasi yaitu segala sesuatu yang mengganggu kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pakar perilaku lain menganggap ansietas sebagai suatu dorongan untuk belajar berdasarkan keinginan dari dari dalam untuk menghindari kepedihan. Individu yang terbiasa dalam kehidupan dirinya dihadapkan pada ketakutan yang berlebihan lebih sering menunjukan ansietas pada kehidupan selanjutnya. Ahli teori konflik memandang ansietas sebagai pertentangan antara dua kepentingan yang berlawanan.

d. Kajian Keluarga

Kajian keluarga menunjukan bahwa gangguan ansietas merupakan hal yang biasa ditemui dalam satu keluarga. Ada tumpang tindih dalam gangguan ansietas dan antara gangguan ansietas dengan depresi.

e. Kajian Biologis

Kajian biologis menunjukan bahwa otak mengandung reseptor khusus untuk berzodiazepines. Reseptor ini mungkin membantu mengatur ansietas. Penghambatan asam amino butirik gamma neuroregulator (GABA) juga mungkin memainkan peran utama dalam mekanisme biologis berhubungan dengan ansietas, sebagamana halnya dengan endrofin. Selain itu, telah dibuktikan bahwa kesehatan umum seseorang mempunyai akibat nyata sebagai predisposisi terhadap ansietas. Ansietas mungkin disertai dengan gangguan fisik dan selanjutnya menurunkan kapasitas seseorang untuk mengatasi stressor.

Menurut Stuart (2007) factor pencetus (presipitasi) yang menyebabkan terjadinya kecemasan antara lain :

1) Ancaman terhadap integritas fisik meliputi ketidakmampuan fisiologis yang akan datang atau menurunnya kapasitas untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari.
2) Ancaman terhadap system diri dapat membahayakan identitas, harga diri, dan fungsi social yang terintegritas ada individu.

7. Penyebab dan Faktor yang mempengaruhi Kecemasan

Menurut murdingsih (2013), factor yang mempengaruhi kecemasan antara lain :

a. Faktor-faktor intrinsic, antara lain :

1) Usia

Menurut murdiningsih (2013), gangguan kecemasan dapat terjadi pada semua usia, lebih sering pada usia dewasa dan lebih banyak pada wanita. Sebagian besar kecemasan terjadi pada umur 21-45 tahun.

Usia menurut (WHO, 2009).

a) *Middle Age* 45-59 tahun

b) *Elderly* 60-74 tahun

c) *Old* 75-90 tahun

d) *Very old* di atas 90 tahun

2) Pekerjaan

Kesibukan yang harus dilakukan terutama untuk menunjang kehidupan dan kehidupan keluarga.

3) Pengalaman

Menurut Kaplan dan Sadock (1997) mengatakan pengalaman awal dalam pengobatan merupakan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga yang terjadi pada individu terutama untuk masa-masa yang akan datang. Pengalaman awal ini sebagai bagian penting

dan bahkan sangat menentukan bagi kondisi mental individu dan kemudian hari. Apabila pengalaman individu tentang operasi kurang, maka cenderung mempengaruhi peningkatan kecemasan saat menghadapi tindakan operasi (murdiningsih, 2013).

4) Konsep diri dan Peran

Konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang diketahui individu terhadap dirinya dan mempengaruhi individu berhubungan dengan orang lain. Menurut Stuart & Sndeen (2007) peran adalah pola sikap perilaku dan tujuan yang diharapkan diri seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Banyak factor yang mempengaruhi peran seperti kejelasan perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan peran, konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran, kesesuaian dan keseimbangan antara peran yang dijalaninya. Juga keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran. Disamping itu pemisahan situasi yang akan menciptakan ketidaksesuaian perilaku peran, jadi setiap orang disibukkan oleh beberapa peran yang berhubungan dengan posisinya pada setiap waktu. Seseorang yang mempunyai peran ganda baik di dalam keluarga atau di masyarakat memiliki kecenderungan

mengalami kecemasan yang berlebih disebabkan kosentrasi terganggu.

b. Faktor-faktor ekstrinisik, antara lain :

1) Kondisi medis (diagnosis penyakit)

Terjadi gejala kecemasan yang berhubungan dengan kondisi medis sering ditemukan walaupun insiden gangguan bervariasi untuk masing-masing kondisi medis, misaknya : pada pasien sesuai hasil pemeriksaan akan mendapatkan diagnose pembedaha, hal ini akan mempengaruhi tingkat kecemasan klien. Sebaliknya pada pasien yang dengan diagnosa baik tidak terlalu mempengaruhi tingkat kecemasan. (Kaplan & Sadock, 2014).

2) Tingkat pendidikan

Pendidikan bagi setiap orang memiliki arti masing-masing. Pendidikan pada umumnya berguna dalam merubah pola piker, pola bertingkah laku dan pola pengambilan keputusan (Notoatmodjo, 2000). Tingkat pendidikan yang cukup akan lebih mudah dalam mengidentifikasi stressor dalam diri sendiri maupun dari luar dirinya. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kesadaran dan pemahaman terhadap stimulus (Jatman, 2014).

3) Akses informasi

Adalah pemberitahuan tentang sesuatu agar orang membentuk pendapatnya berdasarkan sesuatu yang diketahuinya. Informasi adalah segala penjelasan yang didapatkan pasien sebelum pelaksanaan kemoterapi, kemoterapi terdiri dari tujuan kemoterapi, proses kemoterapi, resiiko dan komplikasi serta alternative tindakan yang tersedia, serta proses administrasi (Smeltzer, 2014).

4) Proses adaptasi

Kozier and Oliveri (2014) mengatakan bahwa tingkat adaptasi manusia dipengaruhi oleh stimulus internal dan eksternal yang dihadapi individu dan membutuhkan respon perilaku yang terus menerus. Proses adaptasi sering menstimulasi individu untuk mendapatkan bantuan dari sumber-sumber di lingkungan dimana dia berada. Perawat merupakan sumber daya yang tersedia di lingkungan rumah sakit yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk membantu pasien mengembalikan atau mencapai keseimbangan diri dalam menghadapi lingkungan yang baru.

5) Tingkat social ekonomi

Status social ekonomi juga berkaitan dengan pola gangguan psikiatrik. Berdasarkan hasil penelitian Durhan (2014) dikatehui bahwa masyarakat kelas social ekonomi rendah prevalensi psikiatriknya lebih banyak. Jadi keadaan ekonomi yang rendah atau tidak memadai dapat mempengaruhi peningkatan kecemasan pada klien menghadapi tindakan operasi.

6) Jenis tindakan operasi

Adalah klasifikasi suatu tindakan terapi medis yang dapat mendatangkan kecemasan karena terdapat ancaman pada integritas tubuh dan jiwa seseorang (Long, 2014). Semakin mengetahui tindakan operasi, akan mempengaruhi tingkat kecemasan klien.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PRE OPERASI

1. Pengertian pre operasi

Fase pre operasi adalah : Waktu sejak keputusan untuk operasi hingga sampai ke meja pembedahan, tanpa memandang riwayat atau klasifikasi pembedahan (Muttaqin & Sari, 2009). Menurut Nurachman & Masfuri (2001) pre operasi adalah : awal dimulainya proses setelah ada keputusan pembedahan dan selanjutnya hingga klien diantarkan sampai ke meja operasi. Sedangkan keperawatan pre operatif adalah segala aktifitas yang

dilakukan oleh perawat untuk mensukseskan segala persiapan menjelang operasi. Persiapan yang baik dan hati-hati dapat menurunkan resiko selama operasi dan meningkatkan pemulihan post operasi.

2. Tahapan-tahapan Pre Operasi

Adapun tahap-tahap pre operasi adalah (Nurachmah & Masfuri, 2001) :

a. Di tempat dokter sebelum dibawah ke fasilitas perawatan kesehatan
b. Setelah masuk dan hari-hari sebelum operasi.
c. Malam hari sebelum operasi
d. Pagi hari operasi sebelum pre operasi

3. Pengkajian pada pasien pre operasi

Menurut Muttaqin & Sari (2009) pengkajian pasien pada fase pre operasi secara umum dilakukan untuk menggali permasalahanpada pasien, sehingga perawat dapat melakukan intervensi yang sesuai dengan kondisi pasien.

a. Pengkajian komperehensif yang dilakukan perawat pada bagian rawat inap, poliklinik, bagian bedah sehari, dan unit gawat darurat.

b. Pengkajian klarifikasi ringkas oleh perawat perioperative di kamar operatif.

Pada klien yang akan dioperasi perlu dilakukan pengkajian secara umum yang meliputi :

1) Pengkajian Umum

Hal-hal yang harus diidentifikasi pada saat melakukan pengkajian umum :

a) Identitas pasien

Faktor usia baik anak-anak dan lansia dapat meningkatkan resiko pembedahan. Pada bayi dan anak-anak berhubungan dengan status fisiologis yang masih imatur atau mengalami penurunan, sedangkan lansia kapasitas fisik lansia untuk beradaptasi dengan stress pembedahan menjadi terhambat karena mundurnya beberapa fungsi tubuh tertentu (Muttaqin & Sari, 2009)

b) Jenis pekerjaan dan asuransi kesehatan

Sebelum dilakukan operasi sebaiknya pasien dan keluarga sudah mendapat penjelasan dan informasi terkait masalah finansial, mulai dari biaya operasi hingga pemakaian alat tambahan agar setelah operasi nanti tidak ada complain atau ketidakpuasan pasien dan keluarga (Muttaqin & Sari, 2009).

c) Persiapan umum

Meliputi *informed consent*, persiapan alat, obat yang akan digunakan selama pembedahan dan pencalonan pasien yang akan di lakukan pembedahan (Kozier,Berman & Synder, 2010).

d) Formulir pre operatif di kamar operasi bertujuan untuk mendokumentasikan prosedur secara rutin dilakukan pada pembedahan (Muttaqin & Sari, 2009).

2) Pengkajian riwayat kesehatan

Pengkajian riwayat kesehatan meliputi : penyakit yang pernah diderita pasien, pengalaman bedah sebelumnya (Kozier, Berman & Snyder, 2010).

3) Riwayat alergi

Perawat harus mewaspadai adanya alergi terhadap obat yang mungkin diberikan selama fase intra operatif (Perry & Potter, 2005).

4) Kebiasaan merokok,alkohol dan narkoba

Pasien perokok memiliki resiko mengalami komplikasi paru-paru operasi dan untuk pasien mengkonsumsi alkohol mengakibatkan reaksi yang kurang baik terhadap obat anastesi sedangkan pasien yang mempunyai riwayat adanya pemakaian narkoba perlu diwaspadai atas

kemungkinan yang lebih besar untuk terjangkit penyakit seperti HIV dan Hepatitis (Kozier, Berman, Snyder, 2010).

5) Pengkajian nyeri

Sebelumnya kondisi penyakit dan posisi dapat menimbulkan nyeri pada pasien. Perawat perlu mengkaji pengalaman nyeri pasien sebelumnya, serta penggunaan obat penghilang rasa nyeri (Perry & Poter, 2005).

6) Pengkajian psikososial spiritual

Pengkajian psikospiritual meliputi (Muttaqin & Sari, 2009) :

a) Kecemasan praoperatif

Cemas yang dialami pasien pre operasi diakibatkan karena pasien tidak tahu dampak dari pembedahan dan takut terhadap prosedur pembedahan itu sendiri serta beberapa hal lain seperti masa depan, keuangan dan tanggung jawab keluarga, nyeri, kematian atau perubahan citra diri dan konsep diri.

b) Perasaan

Perawat mendeteksi perasaan tentang pembedahan dari perilaku dan perbuatannya. Pasien yang merasa cemas biasanya sering bertanya, tampak

tidak nyaman, atau secra aktif mencari dukungan dari teman dan keluarga.

c) Konsep diri

Pasien dengan konsep diri positif lebih mampu menerima operasi yang dialaminya.

d) Citra diri

Perawat perlu mengkaji perubahan citra tubuh yang pasien anggap akan terjadi akibat dari operasi.

e) Sumber koping

Perawat perlu mengkaji adanya dukungan yang dapat diberikan oleh anggota keluarga atau teman klien.

f) Kepercayaan spiritual

memainkan peranan penting dalam menghadapi kekuatan dan anastesi. Tanpa memandang agama yang dianut pasien, kepercayaan spiritual dapat menjadi medikasi terapeutik maka segala upaya harus dilakukan untuk membantu pasien mendapat bantuan spiritual yang diinginkan.

g) Pengetahuan, persepsi, dan pemahaman

Perawat harus mempersiapkan pasien dan keluarganya untuk menghadapi pembedahan. Dengan mengidentifikasi pengetahuan, persepsi, dan

pemahaman pasien dapat mambantu perawat merencanakan penyuluhan dan tindakan untuk mempersiapkan kondisi emosional pasien.

7) Pemeriksaan keadaan umum

Pemeriksaan keadaan umum pasien pre operasi meliputi (Muttaqin & Sari 2009) :

1. Usia
2. Tanda distress
3. Berat badan
4. Postur
5. Gerakan tubuh
6. Kebersihan diri

8) Pemeriksaan Diagnostik

Pemeriksan diagnostic pada pasien yang akan menjalani operasi meliputi :

Pemeriksaan skrining rutin dan skrining tambahan. Skrining rutin terdiri dari : pemeriksaan darah lengkap, analisis elektrolit serum, koagulasi, kreatinin serum, dan analisis. Untuk pemeriksaan skrining tambahan meliputi : Sinar-x dada, EKG, MRI, CT-scan, USG, IVP, Echocardiography dan pemeriksaan lain sesuai kebutuhan diagnosis prabedah (Muttaqin & Sari, 2009).

D. TINJAUAN UMUM TENTANG JENIS KELAMIN

1. Defenisi Gender atau Jenis kelamin

Gender sering diartikan sebagai jenis kelamin. Menurut Fakih (2016) Gender merupakan penggolongan secara gramatikal terhadap kata-kata dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya yang secara garis besar berhubungan dengan keberadaan dua jenis kelamin atau kenetralan. Gender juga berkaitan dengan pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan masyarakat. Gender juga merupakan suatu konstruksi budaya yang sifatnya terbuka bagi segala perubahan (Juditha, 2015). Menurut Hungu (2016:43) jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seorang itu dilahirkan. Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan diantara keduanya, dan fungsinya tetap dengan laki-laki dan perempuan yang ada di muka bumi. Seperti pada fakta lapangan yang sering kita temui saat ini, banyak sekali tenaga kerja bagian lapangan pada umumnya didominasi oleh laki-laki, sedangkan pada bagian kantor suatu perusahaan pada umumnya didominasi oleh wanita. Hal tersebut bukanlah merupakan suatu kebetulan, melainkan adanya berbagai macam pertimbangan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan berkaitan dengan spesifikasi dari masing-masing

gender atau jenis kelamin. Faktor jenis kelamin ikut menentukan tingkat partsipasi dan produktivitas seseorang dalam bekerja. Tenaga kerja pada dasarnya tidak dapat dibedakan berdasarkan pada jenis kelamin. Tetapi pada umumnya laki-laki akan lebih produktif untuk pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik. Namun dalam keadaan tertentu kadang produktivitas perempuan bisa lebih tinggi daripada laki-laki, dikarenakan perempuan lebih teliti, sabar, dan tekun.

E. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGETAHUAN

1. Defenisi

Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan suati kejadian tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba (Notoatmojo, 2012).

2. Tingkat pengetahuan di dalam domain kognitif

Menurut Notoatmojo, (2012), menjelaskan bahwa pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat, yaitu :

a. Tahu (*Know*)

Tahu diartika sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

b. Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjalankan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat mengiterprestasikan materi tersebut secara benar.

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada suatu atau kondisi real (sebenarnya).

d. Analisa adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetaoi masih didalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjukan kepada suatu kemampuan untuk meletakan atau menghubungkan bagian-

bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru, dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

f. Evaluasi (*evalution*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilain-penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kritesia yang telah ada.

3. Faktor yang mempengaruhi pengtahuan

Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya pengetahuan adalah sebagai berikut : (Notoatmojo, 2012).

a. Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan sesorang semakin mudah menerima informasi sehibgga banyak pula pengetahuan yang dimiliki.

b. Informasi/media masa

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun nonformal dapat memberikan pengaruh jangka pendek sehingga menghasilkan perubahan atau

peningkatan pengetahuan. Semakin banyaknya informasi dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan sesorang dan dengan pengetahuan menimbulkan kesadaran dan akhirnya sesorang akan bersikap dan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang ia miliki.

c. Sosial budaya dan ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan seseorang tanpa melalui penalaran sehingga bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi sesorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang.

d. Lingkungan

Lingkungan berpengaru terhadap proses masuknya pengetahuan dalam lingkungan tersebut. Lingkungan yang buruk cenderung mendorong sesorang untuk berbuat negative begitu juga sebaliknya.

e. Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan ialah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang

diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu.

f. Usia

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Penelitian oleh Ika Suherlin di Media, yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antaraumur dengan tingkat pengetahuan (Notoatmojo, 2012).

F. TINJAUAN UMUM TENTANG DUKUNGAN KELUARGA

1. Defenisi

Dukungan keluarga merupakan bentuk motivasi dan menawarkan bantuan kapanpun lansia membutuhkannya. Dukunga keluarga menurut House dan Khan (1985), dalam Vrietman (2010) terdapat 4 jenis dukungan keluarga, yaitu dukungan instrumental, (sumber bantuan yang praktis dan nyata),

dukungan informasional (keluarga sebagai pengumpul dan penyalur barang informasi yang dapat dipercaya), dukungan evaluasi (keluarga sebagai pemandu, mediator dalam memecahkan masalah, sumber identitas dan penguat dalam keluarga), dan dukungan emosional (keluarga sebgai tempat istirahat dan relaksasi yang aman dan tenang serta dapat membantu kelola emosi).

Keluarga sebagai sistem sosial memiliki fungsi yang dapat menjadi sumber dukungan terpenting bagi individu, seperti : mendorong rasa saling memiliki diantara anggota keluarga, menjamin persahabatan yang langgeng, dan menanamkan rasa aman bagi anggotanya. Dukungan keluarga yang baik dapat mengurangi terjadinya stressor pada penerima dukungan dan meningkatkan rasa percaya diri sehingga pasien dapat mengatasi keadaannya dengan baik, hal ini dapat menurunkan tingkat depresi lansia. Beberapa faktor dapat mempengaruhi depresi, seperti : penurunan fungsi organ, kehilangan mata pencaharian, perubahan gaya hidup dan lain-lain. Oleh karena itu, penanganan depresi memerlukan pendekatan keluarga dalam mendurukung pasien. Dukungan keluarga dapat mewujudkan melalui empati, perhatian, dorongan, saran, informasi, dan lain-lain. Dengan adanya dukungan keluarga, pasien merasa masih ada yang mendengarkan sehingga pasien dapat mengatasi stress.

Dukungan keluarga merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan karena dukungan keluarga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh signifikan dan merupakan faktor penguat yang mempengaruhi kepatuhan pasien (Fitrianasari et. al.,2017).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Dukungan keluarga

a. Faktor Internal

1) Tahap Perkembangan

Dukungan keluarga didasarkan pada usia sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan individu. Kelompok usia yang bebeda bereaksi berbeda tehadap kesehatan.

2) Pendidikan atau Tingkat Pengetahuan

Tingkat pengetahuan mempengaruhi persepsi individu terhadap dukungan. Kemampuan berpikir individu mempengaruhi pemahaman faktor yang berhubungan dengan penyakit dan kesehatan, Menurut pengetahuan keluarga.

3) Faktor Emosional

Faktor emosional sangat mempengaruhi keyakinannya terhadap dukungan. Mereka yang tidak dapat beradaptasi dengan ancaman penyakit menyangkal gejala penyakit dan tidak mencari pengobatan.

4) Spiritual

Aspek spiritual tampak ketika mereka menjalani kehidupannya. Ini termasuk nilai dan keyakinan yang kita jalankan dan hubungan kita dengan keluarga dan teman.

b. Faktor Eksternal

1) Praktik di keluarga

Cara dan bentuk dukungan keluarga yang diberikan dapat mempengaruhi kemampuan pasien untuk mencapai kesehatan.

2) Faktor sosio-ekonomi

Sosio-ekonomi dapat mengaktifkan risiko penyakit dan berdampak signifikan pada persepsi individu tentang kesehatan mereka. Semakin tinggi tingkat ekonomi, semakin responsive tanda dan gejala penyakit.

3) Latar belakang budaya

Latar belakang budaya mempengarughi keyakinan, nilai, dan kebiasaan individu dalam pemberian dukungan, termasuk dalam penyediaan layanan kesehatan.

3. Jenis-jenis Dukungan Keluarga

a. Dukungan Emosional

Keluarga adalah tempat yang paling aman untuk beristirahat serta untuk menenangkan pikiran. Setiap orang pasti membutuhkan bantuan keluarga. Individu yang

mengahadapi persoalan atau masalah menemukan bahwa ada bantuan dalam keluarga yang bersedia mendengarkan dan memperhatikan masalah yang mereka hadapi.

b. Dukungan Instrumental

Keluarga merupakan sumber bantuan dlam hal pengawasan, kebutuhan individu. Keluarga mencari solusi yang dapat membantu fungsi individu dalam melakukan kegiatan.

c. Dukungan Informasional

Keluarga berfungsi sebagai pemberi dan penyampai informasi bagi anggota keluarganya. Di sini diharapkan bahwa individu dapat menggunakan bantuan informasi dari keluarga untuk mengatasi masalah.

d. Dukungan Penilaian

Keluarga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian masalah. Dukungan dan perhatian keluarga merupakan bentuk penghargaan yang positif terhadap individu.

4. Manfaat Dukungan Keluarga

Menurut Wills (dalam Fitriani, 20110, Dukungan keluarga dikatakan dapat melindungi individu dari efek negatif depresi dan dukungan keluarga berdampak langsung pada kesehatan individu. Bentuk dukungan keluarga secara umum adalah dukungan psikososial, Dukungan psikososial mengacu pada pentingnya komnteks sosial dalam mengelola efek

psikososial yang dialami lansia sebagai akibat dari peristiwa stress. Dalam praktiknya, ini berarti memfasilitasi struktur social local (keluarga, kelompok masyarakat, sekolah) yang mungkin tidak berfungsi lagi sehingga dapat secara efektif mendukung lagi setelah pengalaman hidup yang sulit.

5. Tahapan Dukungan keluarga

Menurut (Mardikanto, 2003) tahapan dukungan keluarga antara lain :

a. Tahapan dukungan dalam pengambilan keputusan.
b. Tahapan dukungan dalam perencanaan kegiatan.
c. Tahapan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan.
d. Tahapan dukungan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan.

G. TINJAUAN UMUM TENTANG RIWAYAT OPERASI

1. Defenisi

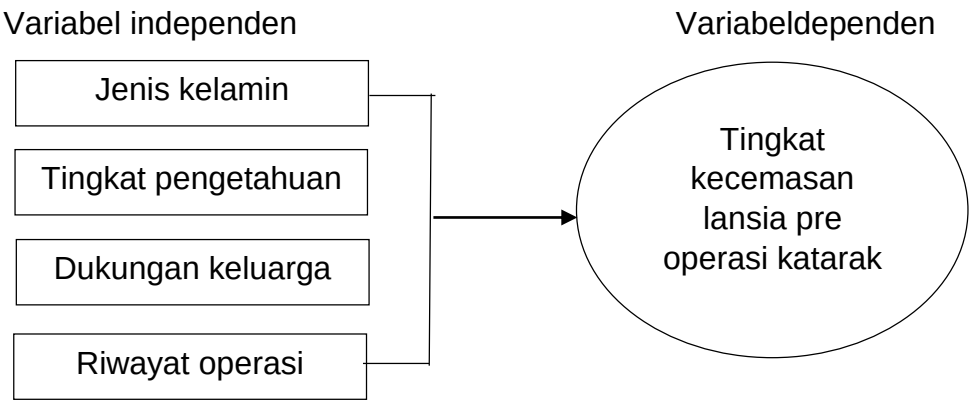
Riwayat operasi mencakup prosedur medis yang telah dilakukan pada seseorang. Ini bisa melibatkan pemindaan organ, perbaikan cedera, atau penanganan kondisi medis tertentu. Riwayat operasi dapat memberikan informasi penting tentang kesehatan seseorang dan mempengaruhi perawatan medis yang mungkin diperlukan di masa yang akan datang.

BAB III

KERANGKA KONSEP, HIPOTESIS DAN DEFENISI OPERASIONAL

A. Kerangka Konsep

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan pada tinjauan pustaka, maka peneliti membuat skema yang menggambarkan variabel independen yaitu Jenis kelamin, tingkat pengetahuan, dukungan keluarga dan riwayat operasi sedangkan variabel dependen yaitu : Tingkat kecemasan lansia pre operasi katarak. Adapun kerangka konsep penelitian ini adalah :



Keterangan :

: Variabel Independen (bebas)

: Variabel Dependen (terikat)

: Hubungan

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

B. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka hipotesisnya adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis Null (H0)
   a. Tidak ada hubungan antara faktor jenis kelamin dengan tingkat kecemasan pasien lansia pre operasi katarak.
   b. Tidak ada hubungan antara faktor tingkat pengetahuan dengan tingkat kecemasan pasien lansia pre operasi katarak
   c. Tidak ada hubungan antara faktor dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien lansia pre operasi katarak
   d. Tidak ada hubungan antara faktor riwayat operasi dengan tingkat kecemasan lansia pre operasi katarak
2. Hipotesis Alternatif (Ha)
   a. Ada hubungan antara faktor jenis kelamin dengan tingkat kecemasan lansia pre operas katarak.
   b. Ada hubungan antara faktor tingkat pengetahuan dengan tingkat kecemasan pasien lansia pre operasi katarak

c. Ada hubungan antara faktor dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien lansia pre operasi katarak
d. Ada hubungan antara faktor riwayat operasi dengan tingkat kecemasan pasien lansia pre operas katarak

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel yang dimaksud, atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan. Secara rinci defenisi operasional pada penelitian ini dijelaskan pada table 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1. Defenisi Opersional

Variabel penelitian	Defenisi operasional	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen				
Jenis kelamin	Perbedaan bentuk, sifat, dan fungsi biologis antara laki-laki dan perempuan yang menentukan perbedaan peran mereka dalam menyelenggarakan upaya meneruskan garis keturunan.	Kuesioner	1. Laki-laki 2. Perempuan	Nominal
Pengetahuan	Segala sesuatu yang diketahui, pedoman dalam membentuk suatu tindakan seseorang, dan dapat juga didefenisikan sebagai hasil penginderaan terhadap segala sesuatu yang telah terjadi dan dilewati berdasarkan pengalaman.	Kuesionar	1. Skor jawaban Benar =1 Skor jawaban salah= 0 2. Tinggi : Jika skor responden > median, 3. Rendah jika skor responden ≤ median.	Ordinal

Dukungan keluarga	Bentuk hubungan interpersonal yang meliputi sikap, tindakan dan penerimaan terhadap anggota keluarga, sehingga keluarga merasa ada yang memperhatikan.	Kuesioner	1. Skor jawaban ya=1 dan skor jawaban tidak=0 2. Tinggi : Jika skor responden > median, 3. Rendah jika skor responden ≤ median.	Ordinal
Riwayat operasi	Riwayat operasi sebelumnya merupakan tindakan operasi yang pernah dilakukan yang akan mempengaruhi tingkat kecemasan yang dialami oleh seseorang	Kuesioner	1. Skor jawaban Ya= 1 Skor jawaban Tidak=0 2. Ya jika responden pernah menjalani operasi 3. Tidak jika responden belum pernah menjalani operasi sebelumnya	Nominal
Variabel Dependen				
Tingkat kecemasan lansia pre operasi Katarak	Suatu respon antisipasi individu terhadap suatu pengalaman yang dianggap dapat menjadi ancaman bagi individu tersebut.	Kuesioner	1. Tidak cemas jika skor < 14. 2. Cemas ringan jika skor 14-20 3. Cemas sedang jika skor 21-27 4.Cemas berat jika skor 28-41 5. Cemas berat sekali jika 42-56	Ordinal

BAB IV

METODE PENILITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasi dengan pendekatan *cross sectional* yaitu penelitian yang diarahkan untuk menghubungan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pasien lansia dengan pre operasi katarak di Klinik Mata Utama Maluku. (Notoatmojo, 2015). Mengidentifikasi cross sectional sebagai satu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada satu saat (*Point time approhch*).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini akan dilaksanakan di Klinik Mata Utama Maluku.

2. Waktu Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November Tahun 2023.

C. Populasi

Menurut Handayani (2020), populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah lansia yang berobat di Klinik Mata Utama Maluku. Populasi dalam penelitian ini adalah 307 orang.

D. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Sampel

Menurut Siyoto & Sodik (2015), Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel dalam penelitian ini adalah lansia yang pre operasi katarak di Klinik Mata Utama Maluku.

Sampel dihitung menggunakan rumus slovin. rumus slovin untuk menentukan sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N\,(e)^2}$$

2. Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Handayani (2020) teknik pengambilan sampel atau biasa disebut dengan sampling adalah proses

menyeleksi sejumlah elemen dari populasi yang diteliti untuk dijadikan sampel, dan memahami berbagai sifat atau karakter dari subjek yang dijadikan sampel, yang nanti akan dapat dilakukan generalisasi dari elemen populasi.

Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah menggunakan teknik *accidental sampling* yang artinya penentuan sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data. (Notoatmojo, 2015).

Adapun sampel yang didapat berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, kriteria inklusi yaitu :

1. Lansia yang akan melakukan operasi katarak
2. Lansia yang bersedia menjadi responden
3. Lansia yang berumur ≤ 45 tahun ke atas

b. Kriteria eksklusi

Kriteria eksklusi adalah subjek penelitian tidak dapat dijadikan sampel karena tidak memenuhi kriteria inklusi

dan memilih sebab-sebab tertentu. Dalam penelitian ini, kriteria eksklusi yaitu :

1. Lansia yang tidak bisa membaca
2. Lansia yang tidak hadir pada saat penelitian

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data dalam melakukan suatu penelitian. Menurut penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun social yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kuesioner Data Demografi

   Kuesioner data demografi digunakan untuk mengetahui data demografi pasien lansia di Klinik Mata Utama Maluku yang meliputi nama (inisial), umur, jenis kelamin, status, dan pendidikan serta riwayat operasi pasien.
2. Kuesioner Tingkat kecemasan.
3. Kuesioner Dukungan keluarga.
4. Kuesioner tentang pengetahuan

F. Proses Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang dipilih peneliti adalah secara komputeralisasi. Data yang terkumpul di olah dengan komputeralisasi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Editing* (Pengeditan)

   Hasil wawancara dilapangan harus di lakukan penyuntingan (*editing)* terlebih dahulu. Secara umum dengan maksud memeriksa kelengkapan data, kesinambungan data dan keseragaman data dalam usaha melengkapi data yang masih kurang.

2. *Coding* (Pemberian kode)

   Untuk memudahkan pengolaan, semua data jawaban disederhanakan dengan memberikan symbol untuk setiap kategori.

   Data coding adalah kegiatan mengklasifikasi data dan memberi kode untuk masing-masing jawaban di kuesioner, sehingga memudahkan untuk memasukan data ke komputer.

   a. Variabel Independen

      1) Variabel jenis kelamin

         a) Laki-laki

         b) Perempuan

2) Variabel pengetahuan memakai 15 pertayaan dengan pilihan jawaban (BENAR) atau (SALAH) skor jawaban BENAR= 1 dan jawaban SALAH = 0. Hasil tinggi = jika skor responden > median, rendah= jika skor responden ≤ nilai median.
3) Variabel dukungan keluarga dengan 16 pertanyaan dengan pilihan jawaban (YA) atau (TIDAK) skor jawaban Ya = 1 dan skor jawaban TIDAK = 0. Hasil tinggi= jika skor responden > median, rendah= jika skor responden ≤ nilai median.
4) Variabel riwayat operasi dengan 3 pertanyaan dengan pilihan jawaban (YA) atau (TIDAK) skor jawaban YA = 1 dan skor jawaban TIDAK = 0. Hasil Ya = jika skor responden pernah menjalani operasi, Tidak = jika responden belum pernah menjalani operasi sebelumnya.

b. Variabel Dependen

Variabel Tingkat kecemasan pre operasi skor 0 = Tidak ada,1 = Ringan, 2 = Sedang, 3 = Berat, 4 = Berat sekali. Hasil 1 = Tidak cemas jika skor < 14, 2 = cemas ringan jika skor 14-20, 3 = cemas sedang jika

skor 21-27, 4 = cemas berat jika skor 28-41, 5 =cemas berat sekali jika skor 42-46.

3. *Tabulating* (Tabulasi)

   Tindakan pengelompokan data dan dimaksud dalam bentuk tabel sesuai dengan skor yang ditentukan pada lembar kuisioner.

4. *Entry* (Pemberian Skor)

   Tahap memasukan data yang diperoleh dengan menggunakan perangkat lunak komputer dengan bantuan SPPS.

G. Analisa Data

Analisa data terdiri dari analisis univariat bivariate. Rincian dari analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Analisa univariat

   Analisa univariat bertjuan untuk mendeskripsikan masing-masing variabel dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berupa Jenis Kelamin, Tingkat pengetahuan, Dukungan keluarga, Riwayat Operasi.

2. Analisa bivariat

   Analisa bivariat bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian dan dilakukan untuk mengidentifikasi variabel

dependen dengan menggunakan uji statistik *chi square* dengan tingkat kemaknaan α 0,05. Sedangkan uji alternatifnya menggunakan uji *fisher exact test*.

H. Etika Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etik yang meliputi :

1. Lembar Persetujuan (*Informed consent*)

   Infomed consent adalah informasi secara lengkap tentang tujuan riset yang akan dilaksanakan dan mempunyai kebebasan dalam berpartisipasi atau menolak menjadi responden. Setiap responden yang menjadi responden diberikan lembar persetujuan beserta penjelasan tentang maksud dan tujuan penelitian, jika menandatangani lembar persetujuan tersebut berarti bersedia, tetapi jika subjek tidak bersedia menjadi responden maka peneliti tidak akan memaksa dan tetap menghargai haknya.

2. Tanpa nama (*Anonimity*)

   Anonimity adalah kerahasiaan identitas atau biodata responden. Untuk menajaga kerahasiaan responden peneliti tidak mencantumkan namanya pada lembar pengumpulan data, cukup dengan memberi nomor kode (nama inisial). Pada masing-masing lembar untuk menjaga privasi.

3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Confidentiality adalah kerahasiaan informasi kelompok data tertentu sebagai hasil riset. Segala informasi yang diperoleh dari responden, peneliti bersedia menjamin kerahasiaannya, hanya pada kelompok tertentu saja yang akan disajikan atau dilaporkan sebagai hasil riset.

4. Menguntungkan & tidak merugikan (*Beneficence & non-maleficence*).

Penelitian yang dilakukan memberikan keuntungan atau manfaat dari penelitian. Proses penelitian yang dilakuka juga diharapkan tidak menimbulkan kerugian atau menimbulkan kerugian yang mungkin ditimbulkan dalam penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui.

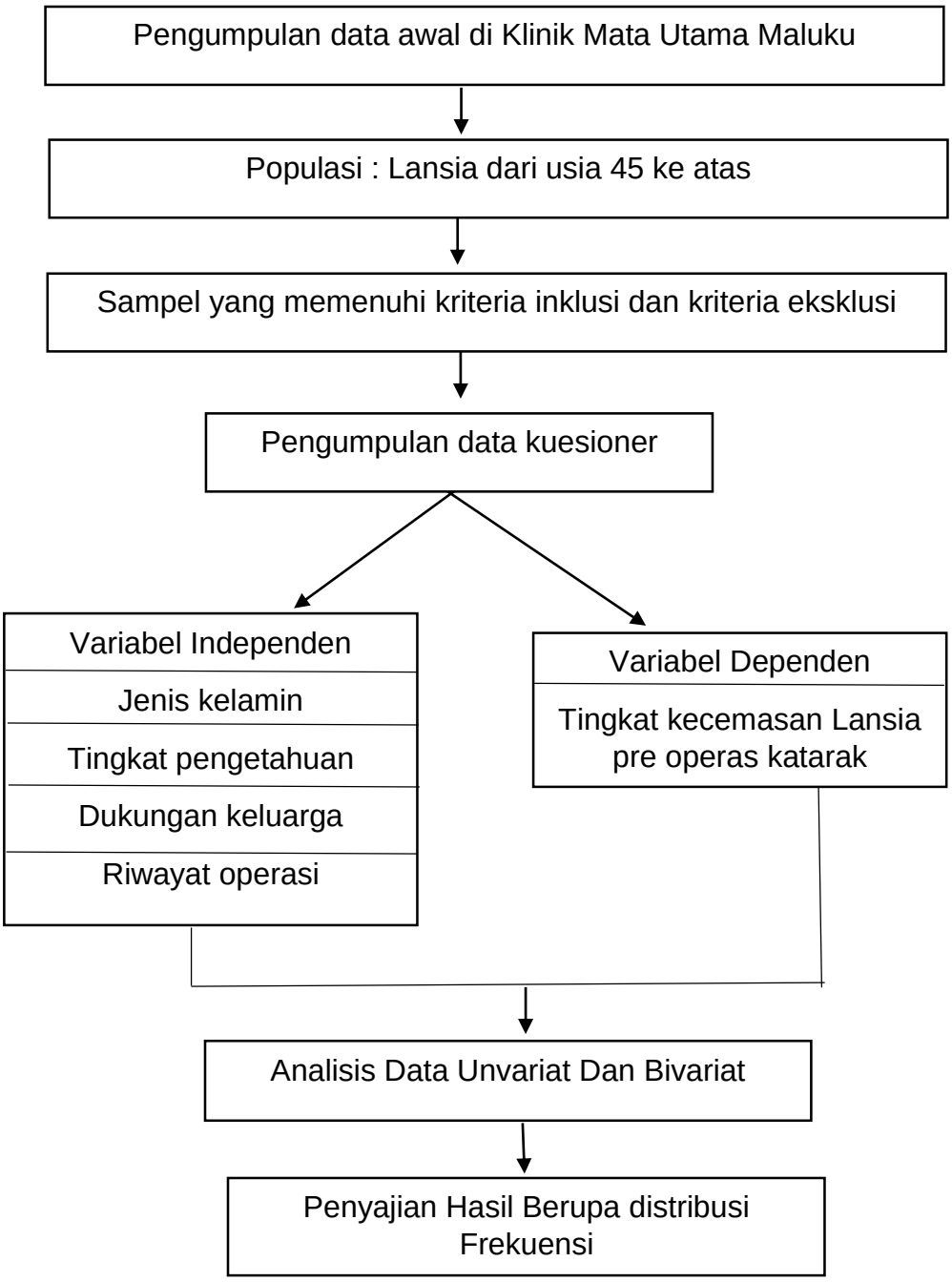
5. Keadilan (*Justice*)

Dalam penelitian ini peneliti tidak memberikan keistimewaan pada salah satu atau beberapa responden dan berusaha untuk bersifat adil pada setiap responden.

Gambar 4.1 Alur Penelitian

I. Alur Penelitian

Bagian alur penelitian dapat digambarkan pada skema dibawah ini :



BAB V
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Klinik Mata Utama Maluku (KMUM) merupakan klinik rawat jalan, terletak di Kota Ambon yang berlokasi di Jl. Dr. Apituley (Belakang Rumah Sakit Tentara) Soabali, Kelurahan Silale. Klinik ini didirikan dan mulai operasional pada tanggal 1 November 2018. Pemilik KMUM adalah seorang dokter spesialis mata, dr. Elna. S. Anakotta, Sp.M, MH. Moto KMUM adalah “ Santun dalam Melayani, cepat dan Tepat dalam Bertindak” merupakan ciri khas dari bentuk pelayanan yang dilakukan.

KMUM memberikan pelayanan bagi pasien BPJS maupun pasien umum. Bentuk pelayanan mencakup Poliklinik mata maupun operasi mata (katarak, pterigium dan lainnya). Semoga KMUM tetap eksis dalam setiap pelayanan dan mendapat kepercayaan dari segenap masyarakat di Provinsi Maluku untuk dapat menuntaskan berbagai permasalahan dalam gangguan kesehatan mata sekaligus mengurangi angka kebutaan akibat katarak di daerah ini.

B. Analisa Univariat

1. Karakteristik Responden

Tabel 5.1
Distribusi Karakteristik Responden Pada Lansia Pre Operasi Katarak di Klinik Mata Utama Maluku

Karakteristik	n	%
Umur		
50-60	14	46.7
61-70	13	43.3
71-80	3	10.0
Jenis Kelamin		
Laki-laki	21	70.0
Perempuan	9	30.0
Pendidikan		
Tidak Sekolah	9	30.0
SD	7	23.3
SMP	3	10.0
SMA	9	30.0
Perguruan Tinggi	2	6.7
Status Menikah		
Menikah	13	43.3
Duda	11	36.7
Janda	6	20.0
Total	**30**	**100.0**

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan Tabel 5.1 diketahui bahwa umur responden yang paling banyak terdapat pada responden dengan umur 50-60 tahun sebanyak 14 responden (46.7%). Responden perempuan sebanyak 9 responden (30.0%) dan laki-laki sebanyak 21 responden (70.0%). Responden yang tidak sekolah sebanyak 9 responden (30.0%), responden yang bersekolah SD sebanyak 7 responden (23.3%), responden yang bersekolah SMP sebanyak 3 responden (10.0%), responden yang bersekolah di SMA sebanyak 9 responden (30.0%) dan sebanyak 2 responden (6.7%) kuliah. Responden yang sudah menikah sebanyak 13 responden (43.3%), responden yang sudah menjadi duda sebanyak 11 responden (36.7%), dan sebanyak 6 responden (20.0%) sudah menjadi janda.

2. Variabel Penelitian

a. Variabel Jenis Kelamin

Tabel 5.2
Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Jenis Kelamin Pada Lansia Pre Operasi Katarak di Klinik Mata Utama Maluku

Variabel	n	%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	21	70.0
Perempuan	9	30.0
Total	**30**	**100,0**

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan Tabel 5.2 diketahui bahwa responden laki-laki sebanyak 21 responden (70.00%) dan perempuan sebanyak 9 responden (30.00%).

b. Variabel Riwayat Operasi

Tabel 5.3
Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Riwayat Operasi Pada Lansia Pre Operasi Katarak di Klinik Mata Utama Maluku

Variabel	n	%
Riwayat Operasi		
Ya	3	10.0
Tidak	27	90.0
Total	**30**	**100,0**

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan Tabel 5.3 diketahui bahwa responden yang memiliki riwayat operasi lebih dari 1 kali sebanyak 3 responden (10.00%) dan yang tidak memiliki riwayat operasi lebih dari 1 sebanyak 27 responden (90.00%).

c. Variabel Dukungan Keluarga

Tabel 5.4

Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Dukungan Keluarga Pada Lansia Pre Operasi Katarak di Klinik Mata Utama Maluku

Variabel	n	%
Dukungan Keluarga		
Rendah	3	10.0
Tinggi	27	90.0
Total	**30**	**100,0**

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan Tabel 5.4 diketahui bahwa responden yang mendapat dukungan keluarga rendah sebanyak 3 responden (10.0%) dan yang mendapat dukungan keluarga tinggi sebanyak 27 responden (90.0%).

d. Variabel Tingkat Pengetahuan

Tabel 5.5
Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Tingkat Pengetahuan Pada Lansia Pre Operasi Katarak di Klinik Mata Utama Maluku

Variabel	n	%
Tingkat Pengetahuan		
Rendah	6	20.0
Tinggi	24	80.0
Total	**30**	**100,0**

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan Tabel 5.5 diketahui bahwa responden yang memiliki tingkat pengetahuan rendah sebanyak 6 responden (20.0%) dan yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi sebanyak 24 responden (80.0%).

e. Variabel Tingkat Kecemasan

Tabel 5.6

Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Tingkat Kecemasan Pada Lansia Pre Operasi Katarak di Klinik Mata Utama Maluku

Variabel	n	%
Tingkat Kecemasan		
Tidak ada	2	6.7
Kecemasan Ringan	1	3.3
Kecemasan Sedang	3	10.0
Kecemasan Berat	11	36.7
Kecemasan Berat Sekali	13	43.3
Total	**30**	**100,0**

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan Tabel 5.5 diketahui bahwa responden yang memiliki tidak memiliki tingkat kecemasan sebanyak 2 responden (6.7%), responden yang memiliki tigkat kecemasan ringan sebanyak 1 responden (3.3%), responden yang memiliki kecemasan sedang sebanyak 3 responden (10.0), responden yang memiliki kecemasan berat sebanyak 11 responden (36.7%), dan responden yang memiliki kecemasan berat sekali sebanyak 13 responden (43.3%).

C. Analisis Bivariat

1. Hubungan antar variabel

   a. Hasil Hubungan Antara Jenis Kelamin Dengan Tingkat Kecemasan Pada Lansia Pre Operasi Katarak Di Klinik Mata Utama Maluku

Tabel 5.7
Hubungan Antara Jenis Kelamin Dengan Tingkat Kecemasan Pada Lansia Pre Operasi Katarak Di Klinik Mata Utama Maluku

			Jenis Kelamin	Tingkat Kecemasan
Spearman's rho	Jenis Kelamin	Correlation Coefficient	1.000	.046
		Sig. (2-tailed)	.	.808
		N	30	30
	Tingkat Kecemasan	Correlation Coefficient	.046	1.000
		Sig. (2-tailed)	.808	.
		N	30	30

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 5.7 diketahui bahwa hasil uji *Korelasi spearman rho* diperoleh nilai korelasi jenis kelamin p=1.000 dan tingkat kecemasan 0.046 dengan hasil p value = 0.808. Dengan demikian, maka HO diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan pada lansia pre operasi katarak di Klinik Mata Utama Maluku.

   b. Hasil Hubungan Antara Riwayat Operasi Dengan Tingkat Kecemasan Pada Lansia Pre Operasi Katarak Di Klinik Mata Utama Maluku

Tabel 5.8
Hubungan Antara Riwayat Operasi Dengan Tingkat Kecemasan Pada Lansia Pre Operasi Katarak Di Klinik Mata Utama Maluku

			Riwayat Operasi	Tingkat Kecemasan
Spearman's rho	Riwayat Operasi	Correlation Coefficient	1.000	.193
		Sig. (2-tailed)	.	.307
		N	30	30
	Tingkat Kecemasan	Correlation Coefficient	.193	1.000
		Sig. (2-tailed)	.307	.
		N	30	30

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 5.8 diketahui bahwa hasil uji *Korelasi spearman rho* diperoleh nilai korelasi riwayat operasi p=1.000 dan tingkat kecemasan 0.193 dengan hasil p value = 0.307. Dengan demikian, maka HO diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara riwayat operasi dengan tingkat kecemasan pada lansia pre operasi katarak di Klinik Mata Utama Maluku.

c. Hasil Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Pada Lansia Pre Operasi Katarak Di Klinik Mata Utama Maluku

Tabel 5.9
Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Pada Lansia Pre Operasi Katarak Di Klinik Mata Utama Maluku

			Dukungan Keluarga	Tingkat Kecemasan
Spearman's rho	Dukungan Keluarga	Correlation Coefficient	1.000	.103
		Sig. (2-tailed)	.	.587
		N	30	30
	Tingkat Kecemasan	Correlation Coefficient	.103	1.000
		Sig. (2-tailed)	.587	.
		N	30	30

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 5.9 diketahui bahwa hasil uji *Korelasi spearman rho* diperoleh nilai korelasi dukungan keluarga p=1.000 dan tingkat kecemasan 0.103 dengan hasil p value = 0.587. Dengan demikian, maka HO diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pada lansia pre operasi katarak di Klinik Mata Utama Maluku.

d. Hasil Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Pada Lansia Pre Operasi Katarak Di Klinik Mata Utama Maluku

Tabel 5.10
Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Dengan Tingkat Kecemasan Pada Lansia Pre Operasi Katarak Di Klinik Mata Utama Maluku

			Tingkat Pengetahuan	Tingkat Kecemasan
Spearman's rho	Tingkat Pengetahuan	Correlation Coefficient	1.000	-.083
		Sig. (2-tailed)	.	.664
		N	30	30
	Tingkat Kecemasan	Correlation Coefficient	-.083	1.000
		Sig. (2-tailed)	.664	.
		N	30	30

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 5.10 diketahui bahwa hasil uji *Korelasi spearman rho* diperoleh nilai korelasi tingkat pengetahuan p=1.000 dan tingkat kecemasan –0.083 dengan hasil p value = 0.664. Dengan demikian, maka HO diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat kecemasan pada lansia pre operasi katarak di Klinik Mata Utama Maluku.

BAB VI
PEMBAHASAN

A. Hubungan Antara Jenis Kelamin Dengan Tingkat Kecemasan Pada Lansia Pre Operasi Katarak Di Klinik Mata Utama Maluku

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi sejak lahir disebut jenis kelamin. Ciri- ciri seksual yang kita kenal dengan laki-laki dan perempuan disebut dengan jenis kelamin (Saputri et al., 2013). Untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis biasanya digunakan dengan istilah jenis kelamin. Sedangkan pembedaan dalam aspek sosial, budaya, dan aspek non biologis lainnya sering kita kenal dengan nama gender.

Berdasarkan tabel 5.7 diketahui bahwa hasil uji *Korelasi spearman rho* diperoleh nilai korelasi jenis kelamin p=1.000 dan tingkat kecemasan 0.046 dengan hasil p value = 0.808. Dengan demikian, maka HO diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan pada lansia pre operasi katarak di Klinik Mata Utama Maluku.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Budi Santoso yang berjudul hubungan antara karakteristik demografi dengan kecemasan pasien pre operasi di RS Islam Amal Sehat Sragen tahun 2008. Penelitian ini tidak sesuai dengan hasil pengamatan tim psikologis independen program kajian psikolgis Universitas Indonesia mendapatkan 56,41 % individu perempuan cenderung lebih berespon

cemas terhadap kejadian fraktur dibandingkan individu laki-laki (Lukman,2009).

Diperkuat dengan teori yang berkaitan dengan kecemasan pada pria dan wanita oleh Sunaryo, 2004 yang menulis dalam bukunya bahwa pada umumnya seorang laki-laki dewasa mempunyai mental yang kuat terhadap sesuatu hal yang dianggap mengancam bagi dirinya dibandingkan perempuan. Laki-laki lebih mempunyai tingkat pengetahuan dan wawasan lebih luas dibanding perempuan, karena laki-laki lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan luar sedangkan sebagian besar perempuan hanya tinggal dirumah dan menjalani aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga, sehingga tingkat pengetahuan atau transfer informasi yang didapatkan terbatas tentang pencegahan penyakit, dan Myers (1983) mengatakan bahwa perempuan lebih cemas akan ketidakmampuannya dibanding dengan laki-laki, laki-laki lebih aktif, eksploratif, sedangkan perempuan lebih sensitif. Penelitian lain menunjukkan bahwa laki-laki lebih rileks dibanding perempuan (Power dalam Myers, 1983) (Creasoft, 2008)

B. Hubungan Antara Riwayat Operasi Dengan Tingkat Kecemasan Pada Lansia Pre Operasi Katarak Di Klinik Mata Utama Maluku

Riwayat operasi sebelumnya merupakan tindakan operasi yang pernah dilakukan yang akan mempengaruhi tingkat kecemasan yang dialami oleh seseorang (Maharani, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran responden banyak yang belum pernah melakukan operasi dan sedikit sekali yang sudah pernah melakukan operasi. hasil ini sesuai dengan penelitian (Rahman and Pubian 2020). Pada saat seseorang masuk dan dirawat di rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya, pola tidur klien dapat dengan mudah berubah dan mengalami gangguan sebagai akibat dari penyakit dan rutinitas pelayanan kesehatan yang tidak diketahui (Potter, Patricia A dan Perry 2012).

Berdasarkan tabel 5.8 diketahui bahwa hasil uji *Korelasi spearman rho* diperoleh nilai korelasi riwayat operasi p=1.000 dan tingkat kecemasan 0.193 dengan hasil p value = 0.307. Dengan demikian, maka HO diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara riwayat operasi dengan tingkat kecemasan pada lansia pre operasi katarak di Klinik Mata Utama Maluku.

Berdasarkan riwayat operasi, mayoritas responden belum pernah menjalani operasi. artinya ini adalah pertama kalinya responden menjalani operasi dan menjadi masalah baru yang harus mereka hadapi. Maka peneliti berasumsi bahwa tingkat kecemasan yang di alami oleh responden bisa jadi karena responden belum mengetahui tentang prosedur dan tindakan operasi. ketidak tahuan pasien akan tindakan operasi akan menimbulkan kecemasan dan mempengaruhi kualitas tidur

C. Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Pada Lansia Pre Operasi Katarak Di Klinik Mata Utama Maluku

Dukungan keluarga menurut Friedman (2013) adalah sikap,tindakan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya, berupa dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental dan dukungan emosional. Jadi dukungan keluarga adalah suatu bentuk hubungan interpersonal yang meliputi sikap, tindakan dan penerimaan terhadap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga merasa ada yang memperhatikan.

Dukungan keluarga yang baik dapat menurunkan tingkat kecemasan yang dialami pasien. Peningkatan kecemasan yang dialami oleh pasien pre operasi dapat menyebabkan tekanan nadi pasien meningkat kemudian gagal untuk menjalani operasi sehingga dapat meningkatkan terjadinya komplikasi.

Berdasarkan tabel 5.9 diketahui bahwa hasil uji *Korelasi spearman rho* diperoleh nilai korelasi dukungan keluarga p=1.000 dan tingkat kecemasan 0.103 dengan hasil p value = 0.587. Dengan demikian, maka HO diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pada lansia pre operasi katarak di Klinik Mata Utama Maluku.

Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Arif Nur Akhmad (2016) yang menyatakan bahwa dukungan keluarga

berhubungan dengan tingkat kecemasan pasien preoperasi. Dukungan keluarga yang baik dapat menurunkan tingkat kecemasan yang dialami pasien. Peningkatan kecemasan yang dialami oleh pasien pre operasi dapat menyebabkan tekanan nadi pasien meningkat kemudian gagal untuk menjalani operasi sehingga dapat meningkatkan terjadinya komplikasi.

Hal ini dikarenakan keluarga yang jarang menemani atau menunggu ketika pasien di rumah sakit, sehingga akan berdampak pada kecemasan yang berat dikarenakan pasien merasa tidak diperhatikan. Selain itu dapat disebabkan juga karena keluarga kurang menyediakan waktu dan fasilitas baik keperluan yang diperlukan pasien ketika dirawat maupun fasilitas uang untuk keperluan biaya perawatan pasien. Keluarga yang tidak pernah memberikan informasi terkait dengan penyakit dan hal-hal yang bisa memperburuk penyakit pasien dan keluarga yang kurang memberikan support agar pasien cepat sembuh.

D. Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Dengan Tingkat Kecemasan Pada Lansia Pre Operasi Katarak Di Klinik Mata Utama Maluku

Menurut Notoadmojo (2003), Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui seseorang setelah melakukan pengindraan terhadap suatu objek yaitu tindakan operasi katarak melalui penginderaan yang terjadi pada panca indera manusia, yaitu indera

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia di peroleh dari mata dan telinga. Dengan adanya pengetahuan yang baik diharapkan dapat mengurangi tingkat cemas, atau depresi pada pasien yang akan menjalani operasi.

Berdasarkan tabel 5.10 diketahui bahwa hasil uji Korelasi spearman rho diperoleh nilai korelasi tingkat pengetahuan p=1.000 dan tingkat kecemasan –0.083 dengan hasil p value = 0.664. Dengan demikian, maka HO diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat kecemasan pada lansia pre operasi katarak di Klinik Mata Utama Maluku.

Hasil tersebut tidak sejalan denga penelitian Rolly R (2014) hubungan pengetahuan dengan tingkat kecemasan pada klien pre operasi katarak di Balai kesehatan mata masyarakat (BKKM) Manado dengan hasil penelitian responden yang tidak memiliki kecemasan dengan berpengetahuan baik. Dapat dikatakan pengetahuan yang semakin baik maka dapat menurunkan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi katarak. Dan sebaliknya, semakin berkurangnya pengetahuan maka kecemasan juga akan bertambah berat. Dari hasil penelitian, dasar teori dan penelitian sebelumnya, dapat diasumsikan bahwa pengetahuan yang baik maka dapat menurunkan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi katarak. Hal ini terbukti dalam penelitian ini dimana sebagian besar pengetahuan responden baik sehingga tingkat kecemasan sebagian besar juga ringan.

Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang akan semakin banyak informasi yang didapat seputar masalah perioperatif sehingga dengan pengetahuan yang didapat dapat mengurangi tingkat kecemasannya. Sebaliknya semakin kurang pengetahuan seseorang tentang proses perioperatif akan membuat dirinya merasa khawatir terhadap proses operasi yang akan dijalaninya sehingga membuat dirinya menjadi tegang dan stres

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan pada lansia pre operasi katarak di Klinik Mata Utama Maluku.
2. Tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pada lansia pre operasi katarak di Klinik Mata Utama Maluku.
3. Tidak ada hubungan antara riwayat operasi dengan tingkat kecemasan pada lansia pre operasi katarak di Klinik Mata Utama Maluku.
4. Tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat kecemasan pada lansia pre operasi katarak di Klinik Mata Utama Maluku.

B. Saran

1. Klinik Mata Utama

   Klinik mata sebagai pemberi layanan jasa kesehatan terhadap masyarakat sehingga dalam pelaksanaan dan pemberian layanan jasa kesehatan klinik mata tahu dan dapat meminimalkan dampak katarak.dan klinik mata dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan mata di klinik mata.

2. Bagi Masyarakat

   Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi pasien yang pre operasi katarak, dimana pasien dapat memahami tentang tingkat kecemasan yang dialami.

3. Peneliti selanjutnya

   Sebagai masukan pengetahuan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pre operasi katarak pada lansia.dan juga sebagai masukan atau acuan untuk penelitian lebih lanjut khususnya dalam hal kecemasan lansia pre operasi katarak.

DAFTAR PUSTAKA

Ady,N.2011,Katarak,Acessed From hhtp://www. hhtp://www.scribd.com/doc/7799037/KTI, Diakes 25 Februari 2013

Agustina, F. (2019). Hubungan Pengetahuan Pasien Tentang Informasi Pre Operasi Dengan Kecemasan Pasien Pre Operasi Di Ruang Rawat Inap. Masker Medikal,Jurnal STIKES Muhamadiyah Palembang Volume 7, Nomor 2, Desember 2019,7.

Anita Royani, Hendra Kusumajaya,Arjuna (2022) Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kejadian Katarak Pada Lansia di Poli Mata.

Apriyansah, A. Hubungan Antara Tingkat Kecemasan Pre Operasi dengan Derajat Nyeri Pada Pasien Sectio Caesarea di Rumah Sakit Muhamadiyah. Palembang ; 2014

Ayuning Mutthia Amila. (2018). Hubungan Efikasi Diri dengan Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi Dirumah Sakit Tingkat III Baladhika Husana Jember. *Digital Respository Universitas Jember*, 1–177

Bachtiar, A. (2021). *Faktor Yang Berhuibungan Dengan Kejadian Katarak Pada Rumah Sakit Universitas Hasanudin*. *10*, 6.

Borrego, A. (2021). *Karakterisitk Kejadian Katarak Di Bagian Mata Rumah Sakit Uumu Daerah (RSUD) Lakipadada Tana Toraja*. *10*, 6.

Crystallography, X. D. (2016a). *Latar Belakang*. *2012*, 1–23.

Depkes RI. Riset Kesehatan Dasar. Jakarta : Badan Penelitan dan Pengembangan Kesehatan Kementrian RI ; 2020.

Ernayani.W.N. (2023). *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Pasien Pre-Operasi Di Ibs Rsud Nyitdah*. file:///D:/Universitas Yatsi Madani/Universitas Yatsi Madani/MK semester 6/bahan metlit/bahan bab 2/NI_WAYAN_ERNAYANI-BAB_IV.pdf

Gupta,V., Rajagopala, M., & Ravishankar, B. (2014). Etiopathologenesis of Catarac: An apraisal. Indian Jurnal of Ophthalmology.

Ilyas & Yulianti (2011) Katarak Lensa Mata Keruh. Kesehatan Masyarakat. Edisi Kedua. Fakulta Kedokteran Universitas Indonesia.Jakarta.

Hawari. Dadan. Manajemen Stress, Cemas, Dan Depresi. Jakarta : FKUI ;

2013

La Ode, Sharif, 2017. Asuhan Keperawatan Gerontik. Yogyakarta : Nuha Medika

Mamu, M., Pelleng, F. A., & Kelles, D. (2012). Pengaruh Doa Kesembuhan Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pasien Katarak Pre Operasi Di Kamar Operasi RSUD ENDE. *Экономика Региона*, *August*, 32.

Miftah Apriani, Niken Puspita Asih (2021) Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kejadian Katarak Pada Lansia.

Mo' otapu, A., Rompas , S., & Bawotong, J. (2015) . Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Penyakit Katarak di Poli Mata Rsup Prof. Dr. RD Kondou Manado. JURNAL KEPERAWATAN.

Murdingsih. (2013). *Penyebab dan Faktor yang mempengaruhi Kecemasan*. 1–58.

Murdingsih, dkk. 2013 Pengaruh Kecemasan Terhadap Kadar Glukosa Darah Pada Penderita Diabetes Militus di Wilayah Banyuanyar Surakarta.

National Eye Institute (2022) Catarac What You Shoul Know, National Eye Institute. Available at: https://www.nei.nih.gov/sites/default/files/healt pdfs/WYS_Catarac_English_sept2015_PRINT.pdf (Accessed: 5 February 2022).

Notoatmojo, S. (2015). Metodologi Penelitian Kesehatan. 3rd edn. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Nursalam. (2020). Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis . Edisi 5. Jakarta : Salemba Medika.

Potter & Perry. 2010 Buku Ajar Fundamental Keperawatan. Jakarta : EGC

Riordan paul-eva.(2017) Anatomi dan Embriologi Mata. Dalam : Vaughen dan Asbury Oftamologi Umum. Edisi ke-17.Jakarta EGC.2017

Rismawan, W. Dkk.(2019). Tingkat Kecemasan Pasien Pre-Operasi DI RSUD dr. SOEKARDJO Kota Tasikmalaya. Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada : Jurnal Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi. Volume 19. Halaman 66-68

Rahmawati, I.,I., Y Widyawati, dan L. Hidayati. 2014 Kenyamanan pasien pre operasi di ruang rawat inap bedah marwah RSU haji surabaya. *Critical, Medical & Surgical Nursing Journal*.

Sitti Humaira Husba Arif (2022) Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi: Literature Review.

Srimahadewi, I. A. G. (2018). Hubungan Tingkat Pengetahuan Pasien Tentang Tindakan Operasi Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi Di Ruang Bima RSUD Sanjiwani Gianyar. *Skripsi*.

Sudrajat, A., Munawir, A., & Supangat, S. (2021). Pengaruh Faktor Risiko Terjadinya Katarak Terhadap Katarak Senil pada petani di Wilayah Kerja Puskesmas Tempurejo Kabupaten Jember. Multidisciplinary journal.

Sugiyono. (2012). Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Bandung Alfabeta.

Stuart G.W, Sundeen. *Principles and Practice of Psykiatri Nursing* (5 th ed.). St. Lous Mosby Year Book; 2007.

LEMBAR KUESIONER DATA DEMOGRAFI

Petunjuk pengisian :

1. Semua pertanyaan harus dijawab.
2. Berilah tanda (√) pada kolom yang disediakan.
3. Isilah pernyataan singkat pada kolom titik-titik (……..).
4. Bila ada yang kurang dimengerti dapat ditanyakan pada peneliti.

a. Nama pasien/Inisiial pasien :……..

b. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki

☐ Perempuan

c. Umur : ……..

d. Status Perkawinan : ☐ Menikah ☐ Tidak menikah

☐ Duda ☐ Janda

e. Pendidikan : ☐ Tidak sekolah ☐ SMP

☐ SD ☐ SMA

☐ Perguruan Tinggi

f. Apakah anda pernah menjalani operasi sebelumnya : ☐ Ya ☐ Tidak

g. Berapa kali anda menjalani operasi :……...

h. Jenis operasi yang anda opernah jalani:……..

KUESIONER TINGKAT KECEMASAN

Hamilton Rating Scale For Anxiety (HRS-A)

PETUNJUK

Skor : 0 = Tidak ada
1 = Ringan
2 = Sedang
3 = Berat
4 = Berat sekali

Total skor : < 14 Tidak ada kecemasan
14-20 Kecemasan ringan
21-27 Kecemasan sedang
28-41 Kecemasan berat
42-56 Kecemasan berat sekali

Berilah tanda silang (X) pada kolom nilai angka (score). Penilaian 0 jika tidak ada gejala sama sekali, 1 jika gejala ringan, 2 jika gejala sedang, 3 jika gejala berat, 4 jika gejala sangat berat.

No	Gejala kecemasan	Nilai angka (score)				
		0	1	2	3	4
1.	Perasaan cemas (anxietas)					
	a. Cemas					
	b. Firasat buruk					
	c. Takut akan pikiran sendiri					
	d. Mudah tersinggung					

2.	Ketegangan					
	a. Merasa tegang					
	b. Lesu					
	c. Tidak bisa istirahat tenang					
	d. Mudah terkejut					
	e. Mudah menangis					
	f. Gemetar					
	g. Gelisah					
3.	Ketakutan					
	a. Pada gelap					
	b. Pada orang asing					
	c. Ditinggal sendiri					
	d. Pada binatang besar					
	e. Pada keramaian lalu lintas					
	f. Pada kerumunan banyak orang Gangguan tidur					
4.	Gangguan tidur					
	a. Sukar tidur					
	b. Terbangun malam hari					
	c. Tidur tidak nyenyak					
	d. Bangun dengan lesu					
	e. Banyak mimpi-mimpi					
	f. Mimpi buruk					
	g. Mimpi menakutkan					
5.	Gangguan kecerdasan					
	a. Sukar konsentrasi					
	b. Daya ingat menurun					
	c. Daya ingat buruk					
6.	Perasaan depresi (murung)					
	a. Hilangnya minat					

	b. Kurangnya kesenangan pada hobi					
	c. Sedih					
	d. Bangun dini hari					
	e. Perasaan berubah-ubah sepanjang hari					
7.	Gejala somatik atau fisik (otot)					
	a. Sakit dan nyeri di otot-otot					
	b. Kaku					
	c. Kedutan otot					
	d. Gigi gemerutuk					
	e. Suara tidak stabil					
8.	Gejala somatik atau fisik (sensorik)					
	a. Tinnitus (telinga berdenging)					
	b. Penglihatan kabur					
	c. Muka merah atau pucat					
	d. Merasa lemas					
	e. Perasaan di tusuk-tusuk					
9.	Gejala kardiovaskuler (jantung dan pembuluh darah)					
	a. Takikardi (denyut jantung cepat)					
	b. Berdebar-debar					
	c. Nyeri di dada					
	d. Denyut nadi mengeras					
	e. Rasa lesu atau lemas seperti mau pingsan					
	f. Detak jantung menghilang atau (berhenti sekejap)					
10.	Gejala respiratory (pernafasan)					
	a. Rasa tertekan atau sempit di dada					
	b. Tercekik					

	c. Sering menarik nafas					
	d. Nafas pendek atau sesak					
11.	Gejala gastroentinatal (pecernaan)					
	a. Sulit menelan					
	b. Perut melilit					
	c. Gangguan pencernaan					
	d. Nyeri sebelum dan sesudah makan					
	e. Perasaan terbakar di perut					
	f. Rasa penuh (kembung)					
	g. Mual					
	h. Muntah					
	i. BAB lembek					
	j. Sukar BAB (konsiptasi)					
	k. Kehilangan berat badan					
12.	Gejala urogenital (perkemihan dan kelamin)					
	a. Sering buang air kecil					
	b. Tidak dapat menahan air seni					
	c. Amenorrhagia (keluar darah banyak ketika menstruasi pada perempan)					
	d. Menjadi dingin (frigid)					
	e. Ejakulassi praecocks					
	f. Ereksi hilang					
	g. Impotensi					
13.	Gejala otonom					
	a. Mulut kering					
	b. Muka merah					
	c. Mudah berkeringat					
	d. Pusing,sakit kepala					
	e. Bulu-bulu berdiri					
14.	Tingkah laku pada wawancara :					

	a. Gelisah					
	b. Tidak tenang					
	c. Jari gemetar					
	d. Kerut kening					
	e. Muka tegang					
	f. Tonus otot meningkat					
	g. Napas pendek dan cepat					
	h. Muka merah					

(Sumber :Aditya Pratama, 2019)

A. Kuesioner Dukungan Keluarga

B. Petunjuk : Berikanlah tanda (√) pada jawaban **YA** bila pertanyaan di bawah ini sesuai dengan perasaan atau keadaan anda, atau pada kolom **TIDAK,** bila pertanyaan di bawah ini tidak sesuai dengan perasaan atau keadaan anda. Jawablah dengan sejujurnya, dan reaksi (jawaban) anda yang pertama pada umumnya adalah yang terbaik.

NO	DUKUNGAN	YA	TIDAK
	Dukungan informasi		
1.	Keluarga memberitahu bahwa penyakit saya bisa sembuh bila menjalani operasi		
2	Keluarga memberi penjelasan setiap saya saya bertanya hal-hal yang tidak jelas tentang penyakit saya		
3	Keluarga menanyakan hasil pemeriksaan dan pengobatan saya kepada dokter		
4	Keluarga menunjukan tempat pelayanan kesehatan yang tepat untuk operasi yang akan saya jalani		
	Dukungan penilaian		
5	Keluarga menguatkan saya untuk tegar dalam menghadapi penyakit		
6	Keluarga menginginkan agar saya memberitahu tentang kondisi kesehatan saya saat menjelang operasi		
7	Keluarga memberikan perhatian kepada saya agar tetap kuat menjalani operasi		
8	Keluarga mengharapkan tindakan operasi yang saya jalani merupakan keputusan yang tepat		

	Dukungan instrmental		
9	Keluarga siap sedia mendampingi saya menjelang operasi		
10	Keluarga memperhatikan perkembangan status kesehatan saya		
11	Keluarga berperan aktif dalam persiapan operasi		
12	Keluarga membantu biaya perawatan dan operasi saya		
	Dukungan emosional		
13	Keluarga mendengarkan keluh kesah saya menjelang operasi		
14	Keluarga mengkhawatirkan kondisi saya menjelang operasi		
15	Keluarga peduli terhadap perasaan takut yang saya alami		
16	Keluarga menyemangati saya dengan mengatakan bahwa operasi akan berjalan lancar		

(Sumber : Anisa mutiara, 2016)

C. Kuesioner tentang pengetahuan

Berilah tanda ceklist (√) pada jawaban benar dan salah

NO	PERNYATAAN	JAWABAN
1.	Klien dilakukan pencukuran bulu mata sebelum operasi katarak	☐ Benar ☐ Salah
2.	Klien dan keluarga menerima penjelasan tentang prosedur operasi sebelum operasi katarak dilakukan	☐ Benar ☐ Salah
3.	Klien diberikan obat tetes mata terlebih dahulu sebelum operasi katarak dilakukan	☐ Benar ☐ Salah
4.	Klien diajarkan latihan napas dalam untuk mengurangi rasa nyeri	☐ Benar ☐ Salah
5.	Klien diminta buang air kecil (BAK) terlebih dahulu sebelum operasi katarak dilakukan	☐ Benar ☐ Salah
6.	Tekanan darah yang tinggi tidak dapat mengakibatkan penundaan operasi katarak	☐ Benar ☐ Salah
7.	Klien diwajibkan puasa 8 jam sebelum operasi katarak	☐ Benar ☐ Salah
8.	Operasi katarak tidak mengakibatkan rasa nyeri	☐ Benar ☐ Salah
9.	Operasi katarak dilakukan jika tajam penglihatan menurun	☐ Benar ☐ Salah
10.	Operasi katarak artinya lensa di mata diganti dengan lensa buatan	☐ Benar ☐ Salah
11.	Tim operasi katarak terdiri dari dokter spesialis mata dan perawat	☐ Benar ☐ Salah
12.	Operasi katarak dilakukan dengan pemberian obat bius lokal	☐ Benar ☐ Salah

13.	Klien tidak boleh berbaring ke arah sisi mata yang telah di operasi	☐ Benar ☐ Salah
14	Klien diperbolehkan menggosok-gosok mata setelah operasi	☐ Benar ☐ Salah
15.	Klien diperbolehkan membuka perban mata sendiri setelah operasi katarak	☐ Benar ☐ Salah

(sumber : wahyuni, 2015)

HASIL OLAH DATA

Frequency Table

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	L	18	60.0	60.0	60.0
	P	12	40.0	40.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Umur Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	50-60	11	36.7	36.7	36.7
	61-70	13	43.3	43.3	80.0
	71-80	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Status Pernikahan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Menikah	13	43.3	43.3	43.3
	Duda	11	36.7	36.7	80.0
	Janda	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Pendidikan Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Sekolah	9	30.0	30.0	30.0
	SD	7	23.3	23.3	53.3
	SMP	3	10.0	10.0	63.3
	SMA	9	30.0	30.0	93.3
	Perguruan Tinggi	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Riwayat Operasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	10	33.3	33.3	33.3
	Tidak	20	66.7	66.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Tingkat Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	6	20.0	20.0	20.0
	Tinggi	24	80.0	80.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Dukungan Keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	3	10.0	10.0	10.0
	Tinggi	27	90.0	90.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Tingkat Kecemasan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak ada	2	6.7	6.7	6.7
	Kecemasan Ringan	1	3.3	3.3	10.0
	Kecemasan Sedang	3	10.0	10.0	20.0
	Kecemasan Berat	11	36.7	36.7	56.7
	Kecemasan Berat Sekali	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Correlations

		Jenis Kelamin	Tingkat Kecemasan
Jenis Kelamin	Pearson Correlation	1	.012
	Sig. (2-tailed)		.949
	N	30	30
Tingkat Kecemasan	Pearson Correlation	.012	1
	Sig. (2-tailed)	.949	
	N	30	30

Correlations

			Jenis Kelamin	Tingkat Kecemasan
Spearman's rho	Jenis Kelamin	Correlation Coefficient	1.000	.046
		Sig. (2-tailed)	.	.808
		N	30	30
	Tingkat Kecemasan	Correlation Coefficient	.046	1.000
		Sig. (2-tailed)	.808	.
		N	30	30

Correlations

		Riwayat Operasi	Tingkat Kecemasan
Riwayat Operasi	Pearson Correlation	1	.105
	Sig. (2-tailed)		.581
	N	30	30
Tingkat Kecemasan	Pearson Correlation	.105	1
	Sig. (2-tailed)	.581	
	N	30	30

Correlations

			Riwayat Operasi	Tingkat Kecemasan
Spearman's rho	Riwayat Operasi	Correlation Coefficient	1.000	.193
		Sig. (2-tailed)	.	.307
		N	30	30
	Tingkat Kecemasan	Correlation Coefficient	.193	1.000
		Sig. (2-tailed)	.307	.
		N	30	30

Correlations

		Dukungan Keluarga	Tingkat Kecemasan
Dukungan Keluarga	Pearson Correlation	1	.119
	Sig. (2-tailed)		.532
	N	30	30
Tingkat Kecemasan	Pearson Correlation	.119	1
	Sig. (2-tailed)	.532	
	N	30	30

Correlations

			Dukungan Keluarga	Tingkat Kecemasan
Spearman's rho	Dukungan Keluarga	Correlation Coefficient	1.000	.103
		Sig. (2-tailed)	.	.587
		N	30	30
	Tingkat Kecemasan	Correlation Coefficient	.103	1.000
		Sig. (2-tailed)	.587	.
		N	30	30

Correlations

		Tingkat Pengetahuan	Tingkat Kecemasan
Tingkat Pengetahuan	Pearson Correlation	1	-.119
	Sig. (2-tailed)		.532
	N	30	30
Tingkat Kecemasan	Pearson Correlation	-.119	1
	Sig. (2-tailed)	.532	
	N	30	30

Correlations

			Tingkat Pengetahuan	Tingkat Kecemasan
Spearman's rho	Tingkat Pengetahuan	Correlation Coefficient	1.000	-.083
		Sig. (2-tailed)	.	.664
		N	30	30
	Tingkat Kecemasan	Correlation Coefficient	-.083	1.000
		Sig. (2-tailed)	.664	.
		N	30	30